Estratégia MED

VESÍCULA E VIAS BILIARES



Renatha Paiva

CRM: 109.768

med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Estratégia MED

SIMULADOS GRATUITOS

RESIDÊNCIA MÉDICA

03/09	9º Simulado Residência Médica
10/09	10º Simulado Residência Médica
17/09	11º Simulado Residência Médica
24/09	12º Simulado Residência Médica
01/10	13º Simulado Residência Médica
08/10	14º Simulado Residência Médica

DOMINGO, A PARTIR DAS 14H

MEGARREVISÃO

Residência Médica



03/09	10:00	Medicina Preventiva
10/09	10:00	Clínica Médica Parte I
17/09	10:00	Clínica Médica Parte II
24/09	10:00	Cirurgia
01/10	10:00	Ginecologia e Obstetrícia
08/10	10:00	Pediatria

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

LESÃO IATROGÊNICA DA VIA BILIAR

Prof. Renatha Paiva

med.estrategia.com

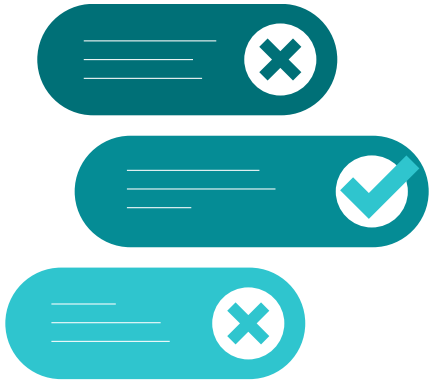
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

LESÃO DA VIA BILIAR

PRINCIPAL CAUSA DE ESTENOSE BENIGNA DA VIA BILIAR.

Mais comum nas colecistectomias laparoscópicas:

- Variações anatômicas da via biliar;
- Hemostasia agressiva, cursando com lesão térmica da via biliar;
- Exposição inapropriada;
- Inflamação intensa na região portal;
- Inexperiência do cirurgião, muito comum naqueles que estão no início da curva de aprendizado da via laparoscópica.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Assinale a alternativa que apresenta a causa mais comum de estenose benigna das vias biliares.

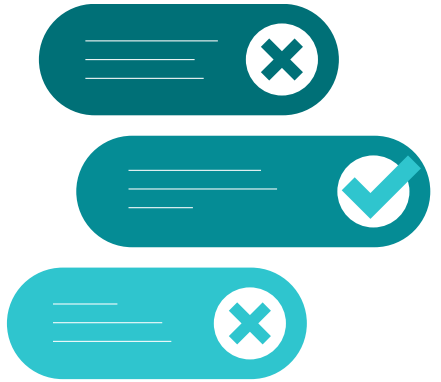
a) Trauma fechado.

b) Pancreatite crônica.

c) Trauma aberto por arma branca.

d) Colangite esclerosante primária.

e) Lesão iatrogênica.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CLASSIFICAÇÃO DE BISMUTH E STRASBERG

CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES IATROGÊNICAS DA VIA BILIAR



Tipo A

Lesão no ducto cístico ou em ductos hepáticos menores que drenam o leito do fígado.



Tipo B

Oclusão de árvore biliar, ducto hepático direito aberrante.



Tipo C

Transecção sem ligação do ducto(s) hepático(s) direito aberrante(s).



Tipo D

Lesão lateral de um ducto biliar maior.

Tipo E (1-5)	Lesão no ducto hepático principal; classificados de acordo com o nível de lesão (ou seja, abaixo).



E1

E1 (Bismuth tipo 1)
Lesão a mais de 2 cm da confluência.



E2

E2 (Bismuth tipo 2)
Lesão a menos de 2 cm da confluência.



E3

E3 (Bismuth tipo 3)
Lesão na confluência; confluência intacta.



E4

E4 (Bismuth tipo 4)
Destruição da confluência biliar.



E5

E5 (Bismuth tipo 5)
Lesão do ducto hepático direito aberrante.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Pela classificação de Strasberg de estenoses pós-operatórias do ducto biliar comum, aquela que ocorre até 2 centímetros da confluência dos ductos hepáticos pertencem ao tipo:

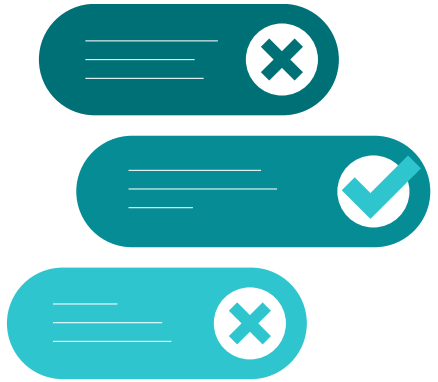
A) E1.

B) E2.

C) E3.

D) E4.

E) E5

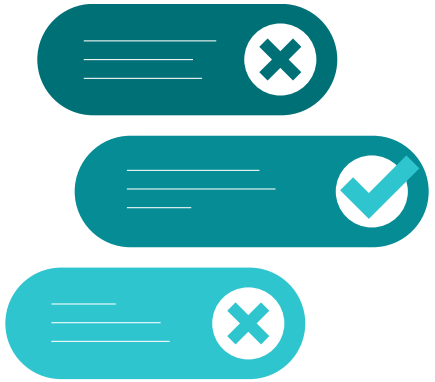


Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

LESÃO DA VIA BILIAR

- ✓ IDENTIFICADA NO INTRA OU NO **PÓS-OPERATÓRIO**
- ✓ ICTERÍCIA NO PÓS-OPERATÓRIO DE COLECISTECTOMIA?

1. LESÃO DA VIA BILIAR
2. COLEDOCOLITÍASE RESIDUAL



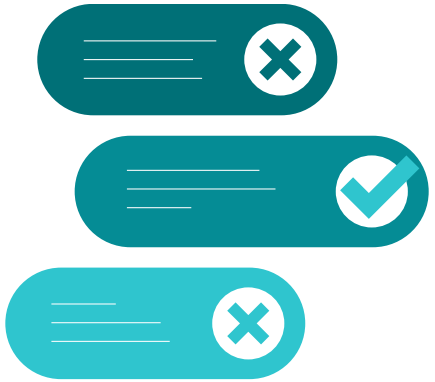
Renatha Paiva

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

LESÃO DA VIA BILIAR

IDENTIFICADA NO INTRA-OPERATÓRIO

- Colangiografia intra-operatória
- Reconstrução imediata
- Lesão não for causada por eletrocautério e < 50% da circunferência: dreno de Kehr
- Lesões térmicas ou > 50% da circunferência: ressecção do segmento lesado e a anastomose biliodigestiva.
- Lesão < 1 cm e distante da confluência dos ductos hepáticos: reanastomose do ducto com anastomose término-terminal (> risco de deiscência)
- Lesões altas, próximas à bifurcação dos ductos hepáticos, ou > 1 cm: reconstrução biliodigestiva (anastomose com o jejuno em Y-de-Roux, seja com o colédoco, seja com o ducto hepático comum)
- Lesões distais do colédoco, junto ao duodeno: reimplantado no duodeno (anastomose colédoco-duodenal) ou anastomose colédoco-jejunal em Y-de-Roux (preferível)



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Durante a cirurgia Vídeo-laparoscópica para tratamento de Colecistite Aguda, quando suspeita-se de Lesão Iatrogênica de Colédoco; Qual é a melhor conduta nesse momento?

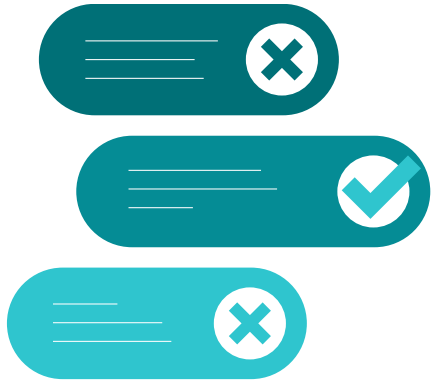
a) Colangiografia intra-operatória.

b) Colangiografia endoscópica retrógrada.

c) Conversão para laparotomia.

d) Colangiografia transparieto-hepática.

e) Conversão para laparotomia e colocação o dreno de Kehr.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Durante colecistectomia vídeolaparoscópica eletiva, ao realizar dissecção do ducto cístico com tesoura, ocorreu lesão menor que 1/4 da circunferência do colédoco a este nível. Qual a melhor conduta a ser realizada no caso em questão?

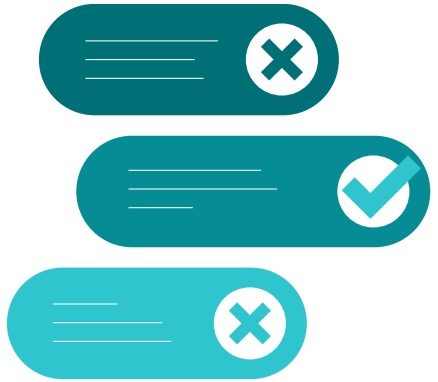
a) Apenas sutura local

b) Sutura e papilotomia

c) Sutura local com colocação de dreno laminar adjacente

d) Proceder a anastomose bilio-digestiva

e) Colocação de dreno de T no colédoco

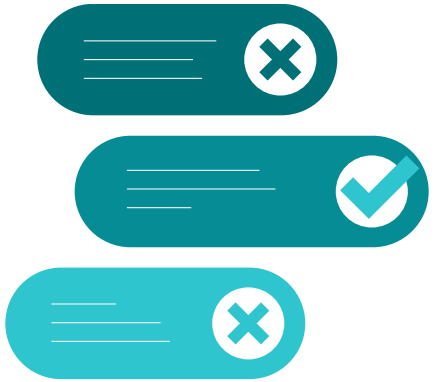


Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

LESÃO DA VIA BILIAR

- ✓ IDENTIFICADA NO INTRA OU NO **PÓS-OPERATÓRIO**
- ✓ ICTERÍCIA NO PÓS-OPERATÓRIO DE COLECISTECTOMIA?

1. LESÃO DA VIA BILIAR
2. COLEDOCOLITÍASE RESIDUAL



Renatha Paiva

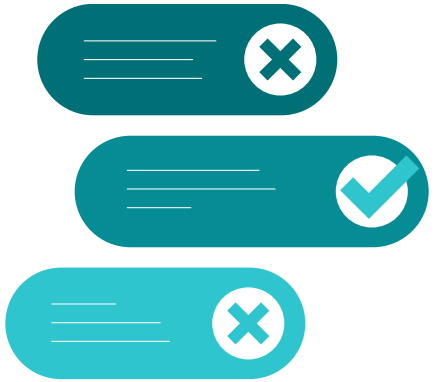
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

LESÃO DA VIA BILIAR

IDENTIFICADA NO PÓS-OPERATÓRIO

- Icterícia
- Dor no hipocôndrio direito
- Saída de bile por um dreno abdominal
- Coleperitônio (peritonite causada pela bile na cavidade abdominal), colangite e sepse abdominal.

CONDUTA = EXAMES DE IMAGEM (USG/TC)



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

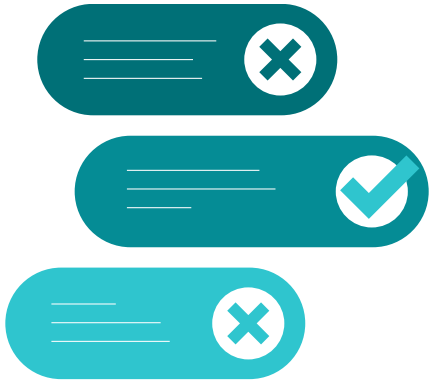
LESÃO DA VIA BILIAR

IDENTIFICADA NO PÓS-OPERATÓRIO – OBJETIVOS:

I. CONTROLE DA INFECÇÃO: antibioticoterapia de largo espectro, drenagem de coleção intracavitária, lavagem e drenagem de cavidade (coleperitônio)

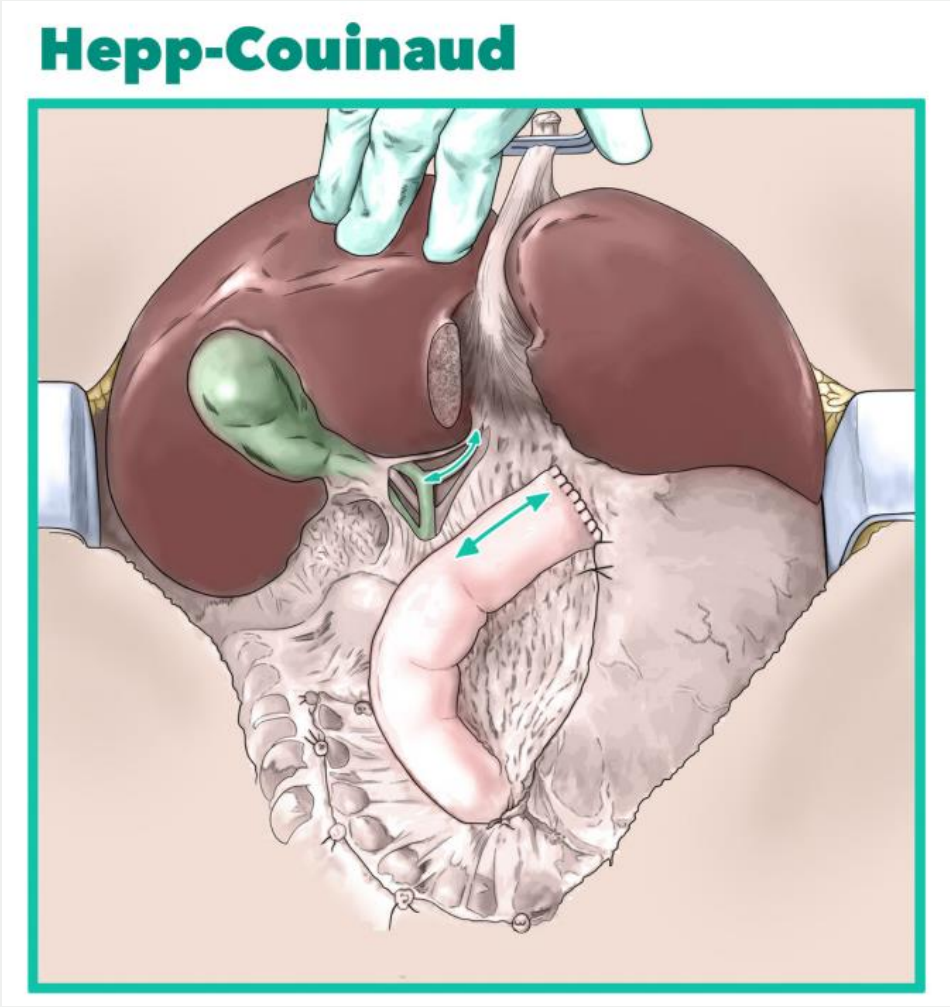
II. DELINEAMENTO DA ANATOMIA BILIAR E PLANEJAMENTO:
- Colangiorressonância;
- Colangiografia percutânea trans-hepática;
- CPRE.

III. REESTABELECIMENTO DA VIA BILIOENTÉRICA: depende do tipo de lesão
- Stent
- Dreno de Kehr
- Ressecção e anastomose primária
- Anastomose biliodigestiva / cirurgia de Hepp-Couinaud (lesões altas da via biliar -E1-E3, anastomose biliodigestiva intra-hepática)



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CIRURGIA DE HEPP-COUINAUD



Anastomose látero-lateral entre o ducto hepático esquerdo e a alça de jejuno exclusa (em Y-de-Roux)

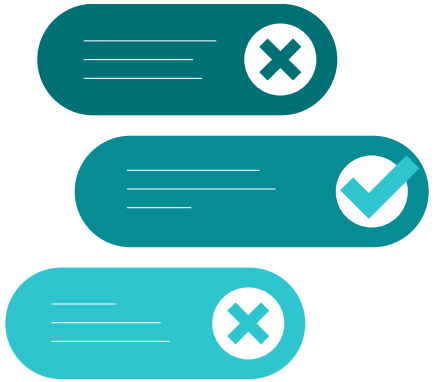
Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

LESÃO DA VIA BILIAR

COMPLICAÇÕES:

- Colangite;
- Fístula biliar externa;
- Abscesso subfrênico e sub-hepático;
- Estenose da anastomose biliodigestiva (em torno de 10% dos pacientes)

Mortalidade cirúrgica: 5 a 8%



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Paciente submetida à colecistectomia videolaparoscópica retorna à emergência no 7º dia pós-operatório com dor abdominal, febre e icterícia. Quando contatado, o cirurgião informa que a cirurgia foi realizada por colelitíase, sem processo inflamatório agudo. Diante desse quadro clínico, a hipótese mais provável é:

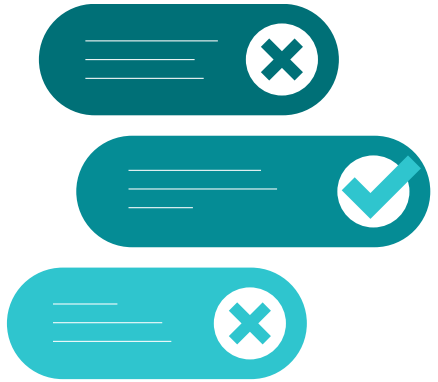
A) Perfuração de víscera oca.

B) Lesão cirúrgica de via biliar.

C) Pancreatite aguda.

D) Hemólise por trauma cirúrgico.

E) Sepse.



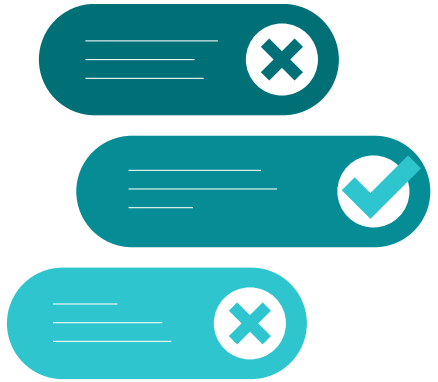
Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

As lesões iatrogênicas das vias biliares consequentes à colecistectomia videolaparoscópica podem implicar em importante morbiletalidade hospitalar e procedimentos complementares para seu tratamento. A política de colecistectomia segura tem sido defendida como um conjunto de estratégias voltadas para minimizar a possibilidade de tais lesões. Em relação à colecistectomia segura, marque ""V"" para verdadeiro ou ""F"" para falso:

( ) A tração medial e cranial do infundíbulo da vesícula, durante a colecistectomia videolaparoscópica, é fundamental para expor adequadamente o triângulo de Calot e reduzir o risco de lesões iatrogênicas das vias biliares.

( ) A visão crítica de segurança durante a colecistectomia videolaparoscópica envolve a identificação inequívoca de duas estruturas anatômicas que confluem no infundíbulo, remoção do tecido conjuntivo e gorduroso entre o ducto cístico e artéria cística e a exposição do terço proximal do leito cístico, após dissecação parcial entre a vesícula e o fígado.

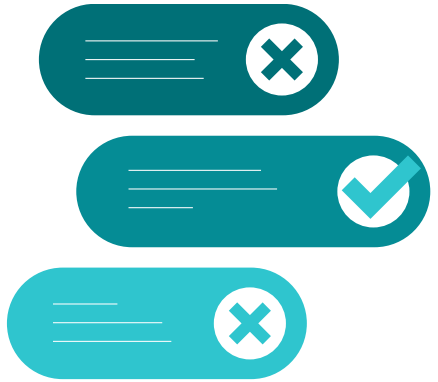


Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

( ) Devido ao risco da síndrome do coto cístico e fístula biliar pós-operatória, a colecistectomia videolaparoscópica parcial não faz parte das estratégias idealizadas pela política de colecistectomia segura.

( ) A maioria das lesões iatrogênicas das vias biliares são identificadas durante a colecistectomia videolaparoscópica e devem ser prontamente corrigidas pelo cirurgião que está realizando o procedimento operatório.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

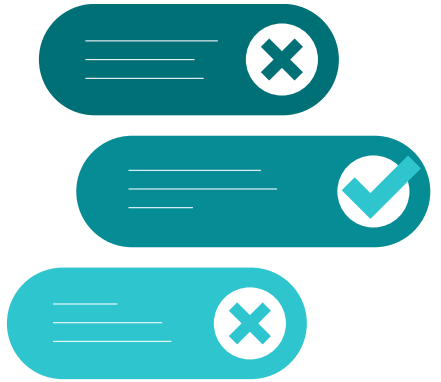
Assinale a sequência CORRETA:

a) V - F - V - F

b) F - V - F - F

c) V - F - V - V

d) F - V - F – V



Renatha Paiva

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Uma paciente de 34 anos de idade foi submetida à colecistectomia videolaparoscópica há um dia devido à colecistopatia crônica calculosa. O intraoperatório mostrava vesícula biliar escleroatrófica, sendo realizado o procedimento com dificuldade técnica e colocado dreno na cavidade abdominal. No primeiro dia pós-operatório, a paciente se encontrava com dor abdominal difusa à palpação, dispneica ++/4+, com saída de secreção biliosa pelo dreno abdominal, com pulso de 130 bpm e PA de 70 x 50 mmHg. Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta.

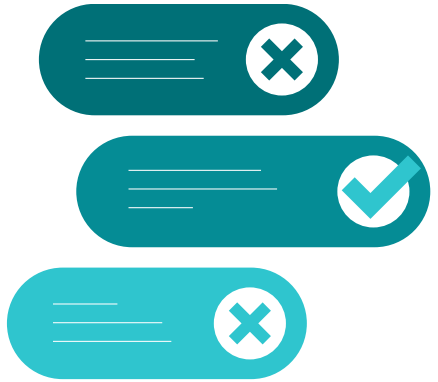
A) revisão cirúrgica da cavidade para lavagem e redrenagem

B) encaminhamento para a UTI para estabilização do quadro

C) realização de colangiopancreatografia por ressonância magnética para avaliação da via biliar

D) colangiopancreatografia retrógrada endoscópica para avaliação e possível tratamento da via biliar

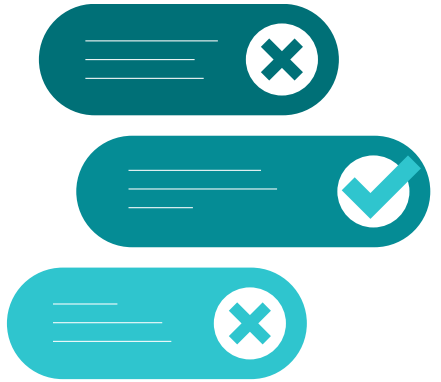
E) solicitação de tomografia de abdome total



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Mulher de 50 anos foi submetida à colecistectomia videolaparoscópica, indicada na urgência, devido diagnóstico de colecistite aguda. Recebeu alta hospitalar no 3º dia de pós-operatório. No 5º dia de pós-operatório, retornou ao pronto-socorro com quadro de dor abdominal, associada a distensão do abdome e vômitos. Ao exame físico, estava em regular estado geral, ictérica, eupneica, estável hemodinamicamente, com abdome distendido e doloroso. Ultrassonografia abdominal revelou a presença de líquido livre em cavidade abdominal. Optou-se, então, por videolaparoscopia, que evidenciou coleperitôneo, porém, não se identificou fístula biliar evidente. Foi realizada a lavagem da cavidade e a drenagem do hilo hepático. Após a cirurgia, houve melhora do quadro abdominal e saída de cerca de 900 mL de bile pelo dreno. Exames complementares mostram leucograma: 14000 células/mm³ (sem desvio); Hb: 10,9 g/dL; Plaquetas: 420000/mm³ ; bilirrubina total: 4,8 mg/dL; bilirrubina direta: 4,0 mg/dL; AST (TGO): 80 U/L; ALT (TGP): 55 U/L; Gama GT: 652 U/L; fosfatase alcalina: 423 U/L; amilase: 90 U/L; RNI: 1,27; albumina: 2,67 g/dL; PCR: 14,5. A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) realizada mostrou a seguinte imagem:



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Nesse momento, a melhor conduta é:

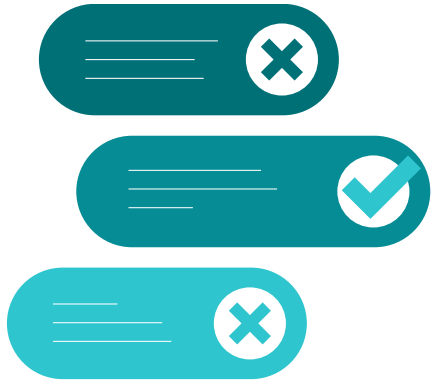
a) Jejum oral e nutrição parenteral.

b) Dieta livre via oral com suplementação enteral.

c) Reconstrução biliar com anastomose término-terminal de colédoco.

d) Ácido ursodesoxicólico e dieta restritiva de gorduras.

e) Derivação bilio-digestiva em Y de Roux.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

PÓLIPOS VESICULARES

Prof. Renatha Paiva

med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

PÓLIPO VESICULAR

Achados incidentais das ultrassonografias de abdome;

Maioria são lesões benignas.

São divididos em dois grupos:

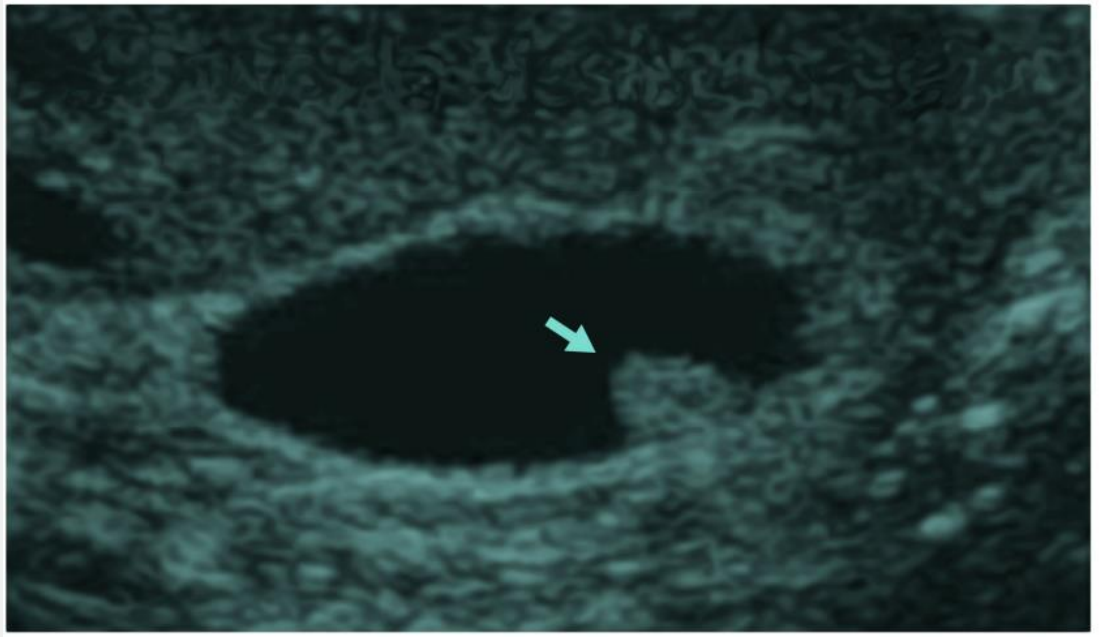
• Pseudotumorais: pólipos de colesterol e a adenomiomatose da vesícula biliar;

• Adenomas: são as lesões que apresentam potencial maligno.

Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

PÓLIPO DE COLESTEROL

Pólipos de colesterol: mais comuns, < 1 cm, múltiplos, lesões ecogênicas, não produzem sombra acústica e não são móveis com o decúbito.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ADENOMIOMATOSE DA VESÍCULA BILIAR

- Crescimento anormal da mucosa da vesícula biliar, espessamento da camada muscular e divertículos intramurais.
- Baixa prevalência, mais comum no sexo feminino.
- USG: pode causar espessamento difuso com focos anecoicos redondos que representam os divertículos intramurais. Quando localizada no fundo, a adenomiomatose pode produzir uma projeção mucosa que pode dar a aparência de um pólipo na ultrassonografia .

Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ADENOMA DA VESÍCULA BILIAR

- Únicos pólipos com potencial de malignidade.
- São tumores epiteliais benignos compostos por células que se assemelham às do epitélio biliar, que podem ser classificadas histologicamente como papilares ou não-papilares.
- USG: difícil diferenciar um pólipo adenomatoso de um adenocarcinoma de vesícula biliar.
- O risco de câncer aumenta conforme o tamanho do pólipo adenomatoso,
  - ✓ Pólipos ≥ 10 mm: risco de malignidade que chega até 55%
  - ✓ Pólipos maiores que 2 cm: são considerados malignos

Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

PÓLIPO DE COLESTEROL	ADENOMIOMATOSE	PÓLIPO ADENOMATOSO
São os mais comuns	Raro	Potencial Maligno
Consequência do acúmulo de lipídios na mucosa da vesícula	Espessamento da camada muscular, apresenta divertículos intramurais	Tumores Epiteliais benignos com células semelhantes ao epitélio biliar
Tamanho < 1 cm	Tamanho > 1 cm	Tamanho variável
Múltiplos	Único	Único
Maioria pediculados	Aspecto séssil	Risco de neoplasia aumenta com o tamanho do pólipo
Aspecto ecogênico na USG, não apresentam sombra acústica posterior	Aspecto séssil, localizada no fundo da vesícula, associado a microcistos	Difícil diferenciação com o adenocarcinoma de vesícula biliar

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

PÓLIPO VESICULAR

INDICAÇÃO DE COLECISTECTOMIA NO PÓLIPO DE VESÍCULA BILIAR
Pacientes sintomáticos (pólipo simulando cólica biliar)
Pólipos maiores que 10 mm em paciente assintomático
Pólipo em crescimento (aumento > 2 mm)
CEP sem cirrose com pólipos de qualquer tamanho CEP com cirrose com pólipos > 8 mm
6 - 9 mm: idade > 60 anos, etnia indiana, pólipo séssil com espessura focal da parede da vesícula biliar > 4 mm

Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

PÓLIPO VESICULAR

Nos pacientes que não se enquadram nesses casos, está indicado o controle com ultrassonografia abdominal.

- 6 e 9mm: 6/6 meses até um ano; depois, anual;
- ≤ 5mm: anual

PÓLIPO MAIOR QUE 2 CM = COLECISTECTOMIA ABERTA

Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Um homem de 24 anos é submetido a ultrassonografia de abdômen, por dor abdominal inespecífica. São achados 3 pólipos de vesícula biliar, medindo em torno de 8 mm cada um. Conduta:

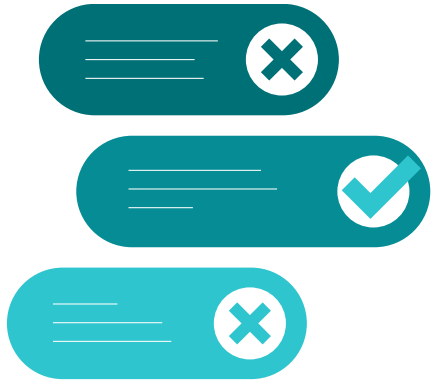
A) Tomografia de abdômen.

B) Ecoendoscopia.

C) Colecistectomia laparoscópica.

D) Controle ultrassonográfico em 6 meses.

E) Colangiorressonância



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Paciente realiza “ultrassonografia de rotina” solicitada por médico assistente. Sobre a imagem abaixo e provável diagnóstico, assinale a alternativa correta:

a) Todos os pacientes que apresentam a alteração visualizada no exame acima têm indicação cirúrgica.

b) A maioria das lesões apresentadas no exame são adenomas.

c) Lesões maiores que 5 mm têm potencial maligno.

d) Trata-se de uma lesão homogênea, ecogênica, com forte sombra acústica posterior e móvel ao decúbito;

e) A conduta mais adequada, neste momento, é o seguimento com ultrassonografia seriada.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

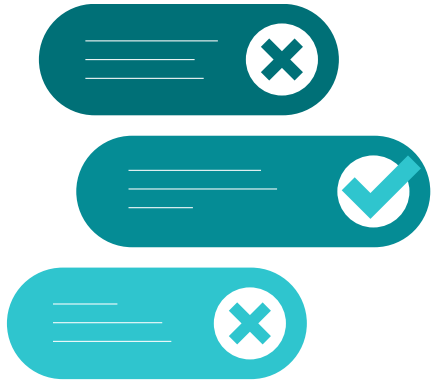
Paciente feminina, de 60 anos, assintomática, realizou ultrassonografia abdominal que identificou pólipo de 0,7 cm na vesícula biliar. Encontrava-se em tratamento para colangite esclerosante primária. Considerando o quadro, que conduta, dentre as abaixo, é a mais adequada?

a) Realizar acompanhamento anual com ultrassonografia abdominal.

b) Realizar colecistectomia videolaparoscópica.

c) Realizar ultrassonografia endoscópica para avaliar a base da lesão polipoide.

d) Solicitar dosagens de CEA e CA 19-9.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Mulher de 62 anos de idade realizou um ultrassom de abdome superior no qual se evidenciou um pólipo em vesícula biliar de 1,5 cm, com fluxo sanguíneo detectado ao doppler. Não tem sintomas.

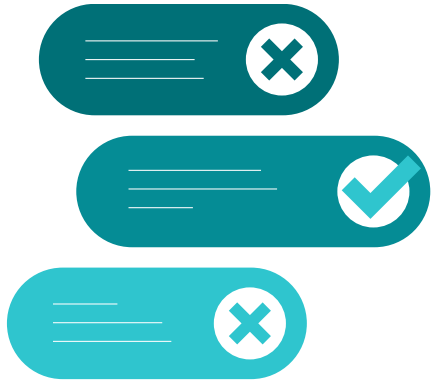
Qual é a melhor conduta para o caso?

a) Colecistectomia por via videolaparoscópica.

b) Colecistectomia por via aberta.

c) Repetir ultrassom de abdome superior em 6 meses.

d) Repetir ultrassom de abdome superior em 12 meses.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SÍNDROME DE MIRIZZI

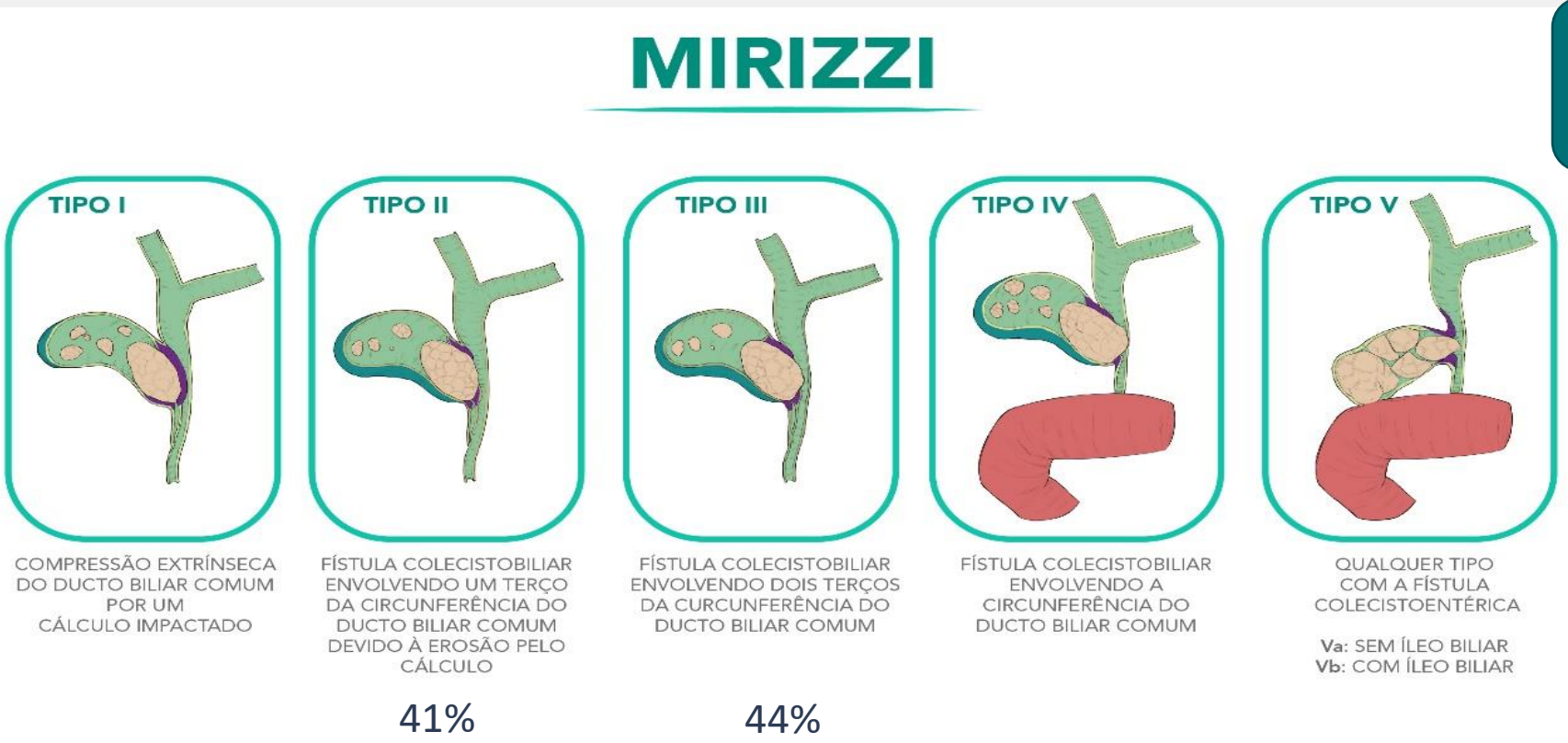
Prof. Renatha Paiva

med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SÍNDROME DE MIRIZZI - Classificação de Csendes

Obstrução do ducto hepático comum causada por compressão extrínseca de um cálculo impactado no ducto cístico ou no infundíbulo da vesícula biliar



Fator de risco para neoplasia!

Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SÍNDROME DE MIRIZZI

EPIDEMIOLOGIA: 0,05% a 4% dos pacientes submetidos a colecistectomia e é mais comum no sexo feminino

CLÍNICA: icterícia, febre e dor abdominal no hipocôndrio

IMAGEM: USG/**COLANGIORRESSONÂNCIA**/CPRE

- Dilatação da via biliar acima do colo da vesícula biliar;
- Presença de cálculo impactado no colo/infundíbulo da vesícula biliar;
- Uma mudança abrupta do diâmetro normal do colédoco abaixo do nível do cálculo

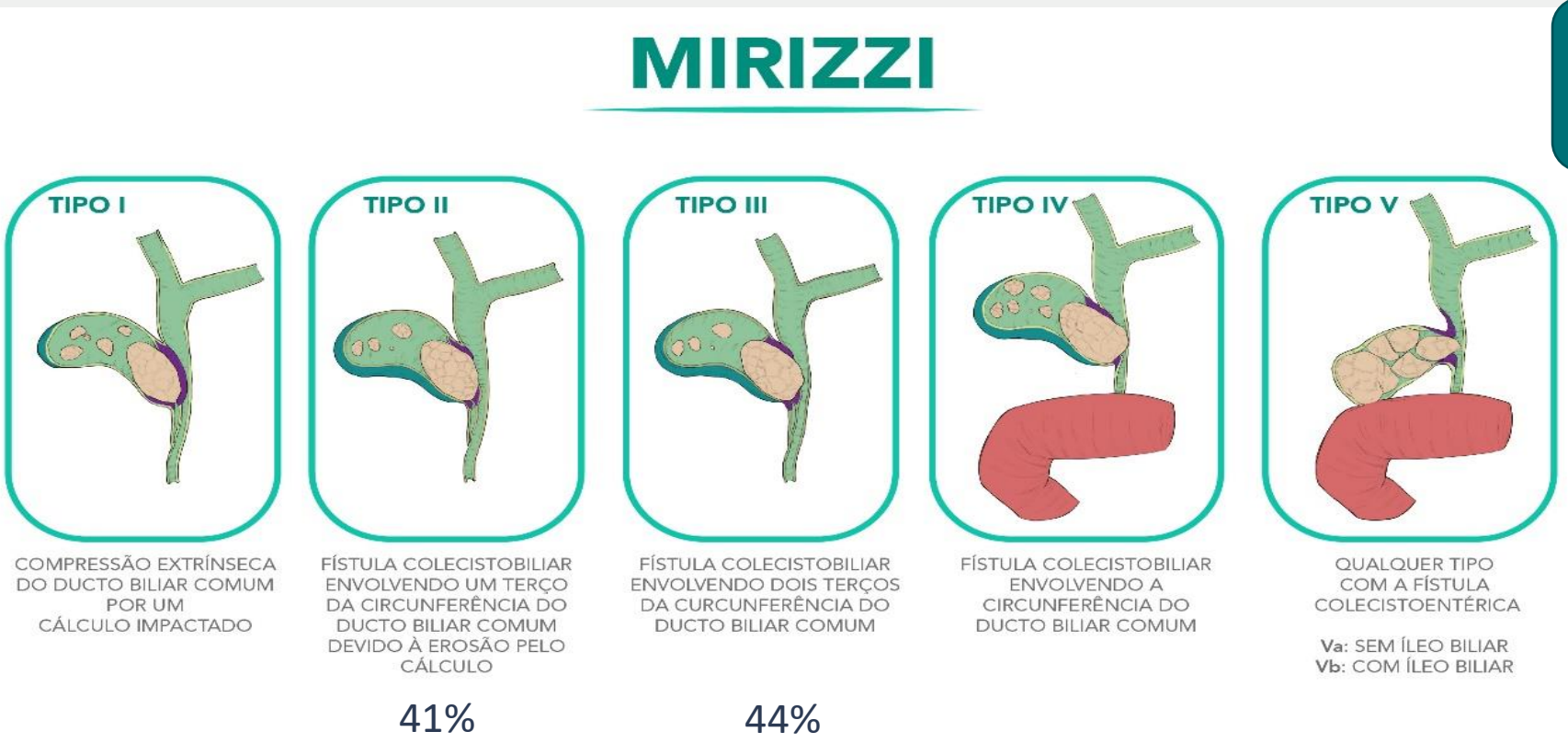
INTRAOPERATÓRIO: COLANGIOGRAFIA



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SÍNDROME DE MIRIZZI - Classificação de Csendes

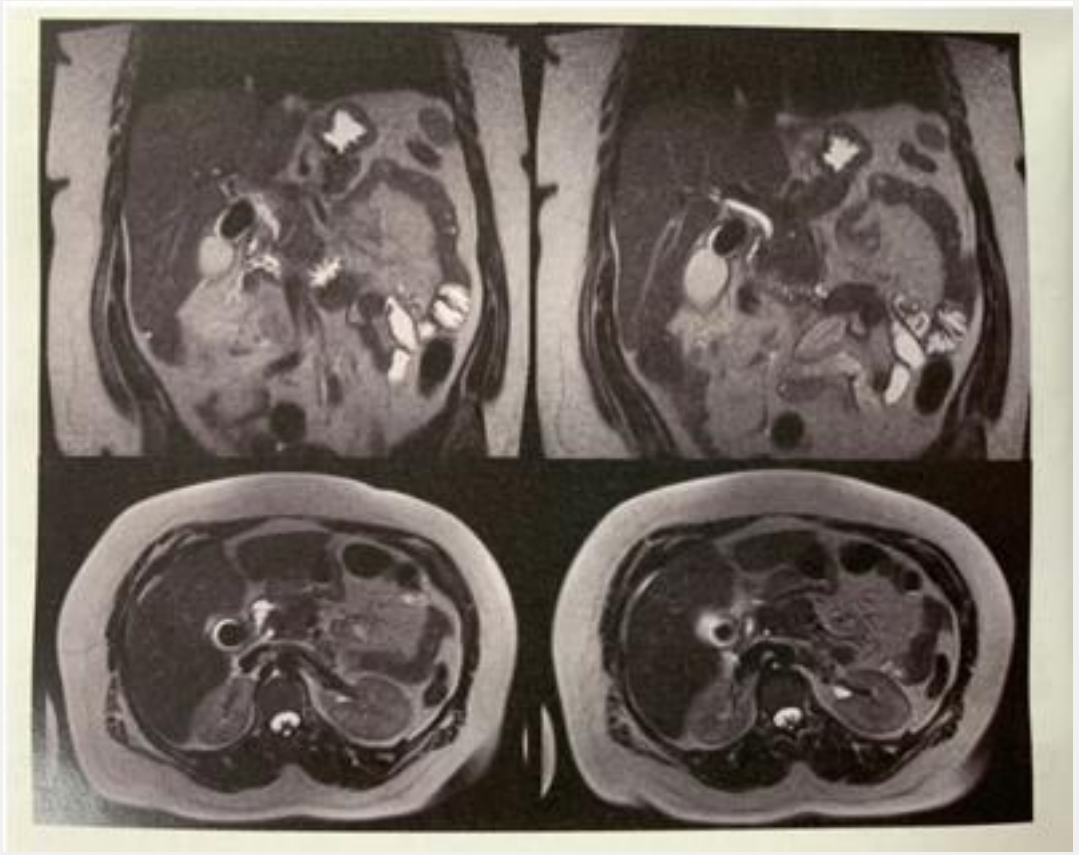
Obstrução do ducto hepático comum causada por compressão extrínseca de um cálculo impactado no ducto cístico ou no infundíbulo da vesícula biliar



Fator de risco para neoplasia!

Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SÍNDROME DE MIRIZZI





Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

A síndrome de Mirizzi é caracterizada por

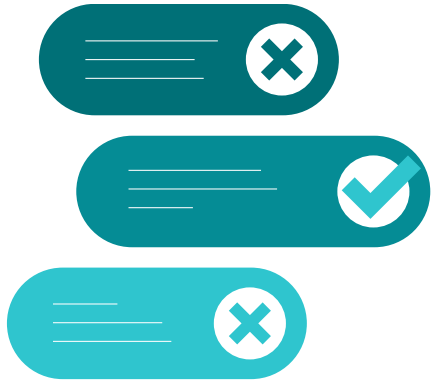
a) compressão da via biliar, com ou sem fístula, por um cálculo biliar impactado no infundíbulo da vesícula.

b) cálculo impactado na papila duodenal causando dilatação das vias biliares com ou sem fístula.

c) cálculo na via biliar principal causando dilatação intra-hepática com ou sem fístula.

d) cálculos intra-hepáticos com abcesso e icterícia obstrutiva.

e) cálculo impactado na confluência dos hepáticos causando icterícia.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

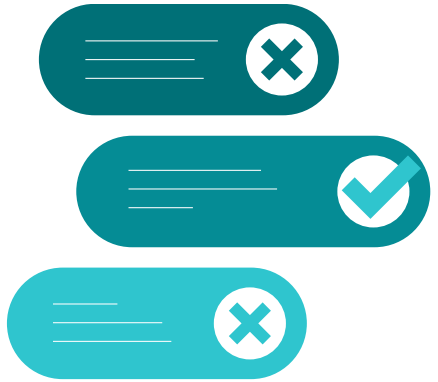
Sobre a síndrome de Mirizzi marque a alternativa errada:

A) O principal fator de sucesso no tratamento é o reconhecimento precoce

B) Dificilmente cursa com icterícia

C) O tipo de tratamento vai depender do grau de acometimento da via biliar principal

D) A colangioressonância é o método de maior sensibilidade ao diagnóstico



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Um paciente é submetido à uma laparotomia de urgência cujo achado foi uma fístula colecistobiliar envolvendo dois terços da circunferência do duto biliar comum. A correta classificação da Síndrome de Mirizzi, é:

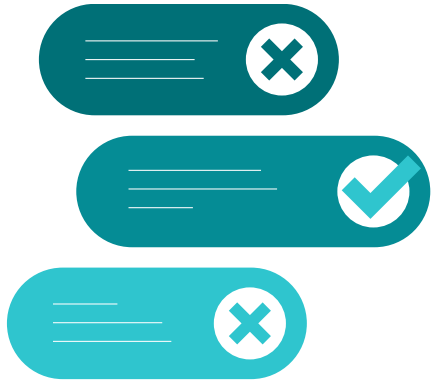
a) Tipo I

b) Tipo II

c) Tipo III

d) Tipo IV

e) Tipo V



Renatha Paiva

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRATAMENTO

Tipo	Tratamento
I	Colecistectomia parcial ou total, laparoscópica ou aberta. Normalmente, a exploração do ducto biliar não é necessária.
II	Colecistectomia mais fechamento da fístula, seja por sutura com material absorvível, colocação de tubo T (Kher) ou coledocoplastia com a vesícula biliar remanescente.
III	Coledocoplastia ou anastomose biliodigestiva, dependendo do tamanho da fístula. A sutura da fístula não é indicada.
IV	A anastomose biliodigestiva, tipicamente coledocojejunostomia, é preferida porque toda a aprede do ducto biliar comum foi destruída.

Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

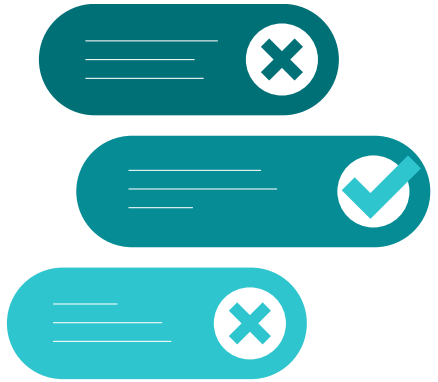
Mulher, 40 anos, refere dor abdominal recorrente em região de hipocôndrio direito relacionada à ingesta de alimentação gordurosa, todavia nunca foi realizada investigação diagnóstica. Posteriormente, percebeu icterícia leve e procurou atendimento médico. Nega febre associada. Exame físico: estável hemodinamicamente; ictérica (1+/4+). Ultrassonografia (US) de abdome superior: vesícula biliar com parede de 2mm contendo cálculo de 2cm em seu interior; dilatação de via biliar até nível de ducto cístico, sugestivo de compressão extrínseca. Pode-se afirmar que a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta mais adequada são:

a) colangite / colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.

b) síndrome de Mirizzi tipo I / colecistectomia.

c) colecistite aguda / colecistectomia.

d) síndrome de Mirizzi tipo II / ressecção de via biliar e derivação biliodigestiva.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Paciente de 63 anos, com história de dor em hipocôndrio direito há 4 anos. Refere vários atendimentos em UPA e 2 internamentos com antibioticoterapia. Relata ainda 3 episódios de icterícia e colúria. Gama GT 4x acima do valor normal. USG - colelitíase com dilatação de vias biliares intra-hepáticas. A CPRE não foi resolutiva, mostrando obstrução calculosa da via biliar comum. O achado cirúrgico foi de uma fístula colecistobiliar, envolvendo toda a circunferência coledociana. No ponto de vista sindrômico, podemos descrever esse caso como:

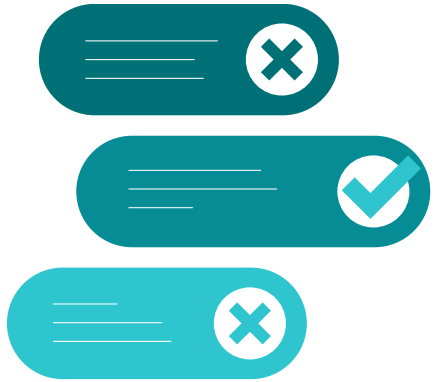
a) Síndrome de Bouveret.

b) Cisto de colédoco tipo II.

c) Síndrome de Mirizzi tipo IV.

d) Calculose intra-hepática.

e) Síndrome de Boerhaave.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Um paciente de 68 anos de idade, diabético controlado, dá entrada no hospital com sepse de foco abdominal, taquicárdico, dispneico, com murphy + à palpação e abdome muito distendido com relatos de parada de eliminação de gazes e fezes. Realizou ultrassom de abdome que evidenciou colecistite aguda enfisematosa complicada e bloqueada. Foi submetido a laparatomia exploradora em que se notou fístula entre a vesícula e duodeno e com cálculo biliar impactando a válvula íleo cecal, caracterizando um síndrome de Mirizzi com íleo biliar. Nessa situação, a melhor conduta e a classificação do Mirizzi seriam, respectivamnete:

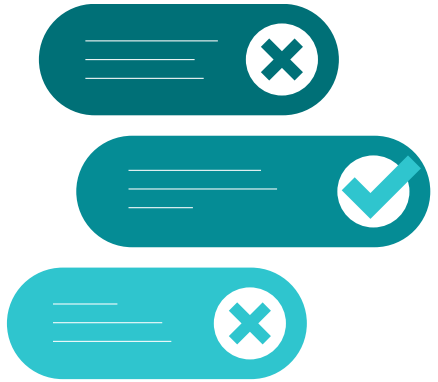
a) colectomia direita e drenagem percutânea da via biliar e Mirizzi tipo II.

b) ileostomia em alça com colangiografia intraoperatória e Mirizzi tipo IV.

c) enterotomia com retirada do cálculo com colecistectomia e Mirizzi tipo Vb.

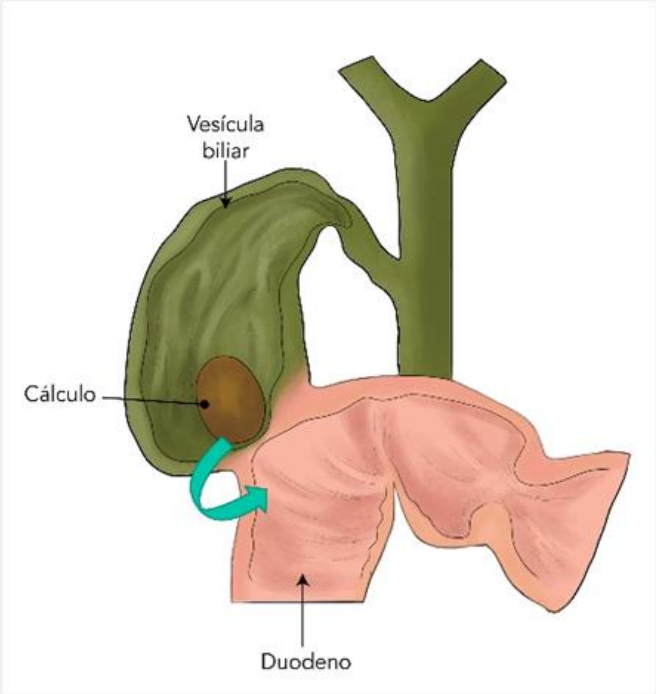
d) colostomia em Alça com colecistectomia e Mirizzi tipo III.

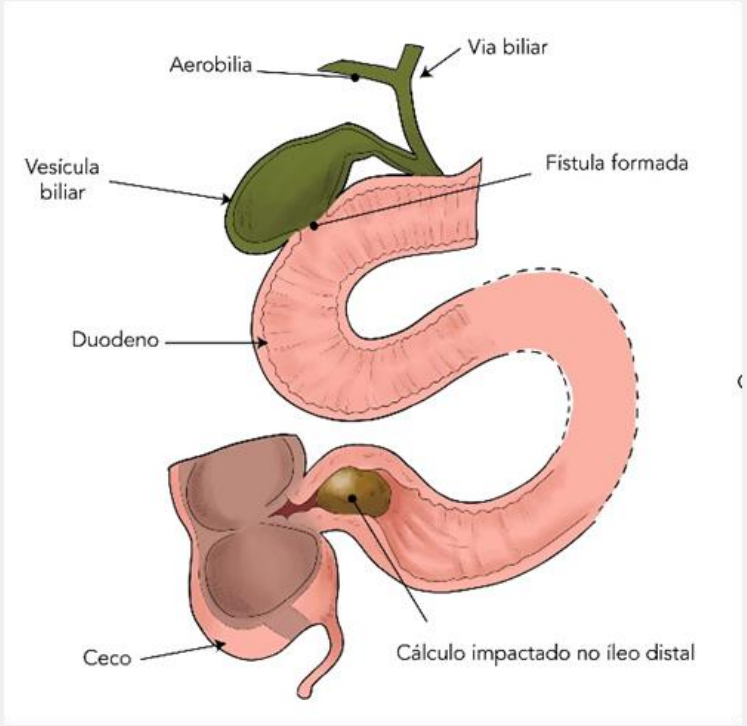
e) enterectomia com colecistendese e Mirizzi tipo Va.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ÍLEO BILIAR







Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ÍLEO BILIAR







TRÍADE DE RIEGLER

Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ÍLEO BILIAR - TRATAMENTO

- Cirurgia = Laparotomia e enterotomia, retirada do cálculo e enterorrafia.
- Pacientes de baixo risco (ASA I ou II): acrescentar procedimento íleo-biliar (colecistectomia e fechamento da fístula).



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Um paciente de 68 anos de idade, diabético controlado, dá entrada no hospital com sepse de foco abdominal, taquicárdico, dispneico, com murphy + à palpação e abdome muito distendido com relatos de parada de eliminação de gazes e fezes. Realizou ultrassom de abdome que evidenciou colecistite aguda enfisematosa complicada e bloqueada. Foi submetido a laparatomia exploradora em que se notou fístula entre a vesícula e duodeno e com cálculo biliar impactando a válvula íleo cecal, caracterizando um síndrome de Mirizzi com íleo biliar. Nessa situação, a melhor conduta e a classificação do Mirizzi seriam, respectivamnete:

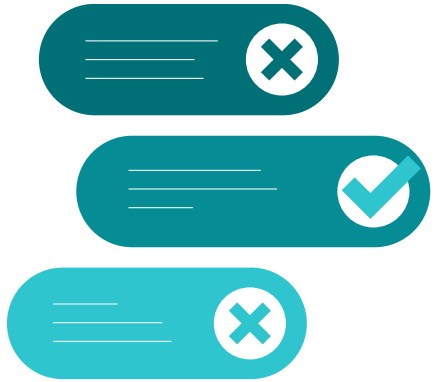
a) colectomia direita e drenagem percutânea da via biliar e Mirizzi tipo II.

b) ileostomia em alça com colangiografia intraoperatória e Mirizzi tipo IV.

c) enterotomia com retirada do cálculo com colecistectomia e Mirizzi tipo Vb.

d) colostomia em Alça com colecistectomia e Mirizzi tipo III.

e) enterectomia com colecistendese e Mirizzi tipo Va.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CISTOS DA VIA BILIAR

Prof. Renatha Paiva

med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CISTOS DA VIA BILIAR

- Patologia rara, ocorrendo em menos de 1 paciente a cada 100 mil.
- Mais comuns em descendentes de asiáticos.
- Acometem mais o sexo feminino que o sexo masculino (3:1).
- O diagnóstico é mais comum na população pediátrica.
- Fisiopatologia: principal hipótese é a presença de uma junção biliopancreática anômala, com o ducto pancreático juntando-se ao colédoco mais de 1 cm da ampola de Vater (refluxo das enzimas pancreáticas). Essa alteração está presente em mais de 90% dos pacientes com cistos biliares.
- CONDIÇÃO PRÉ-MALIGNA: 10 A 30%



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

QUADRO CLÍNICO

Maioria dos pacientes apresentará cistos biliares antes dos 10 anos de idade.

TRÍADE CLÁSSICA (menos da metade dos casos):

- Dor abdominal;
- **Icterícia;**
- Massa palpável

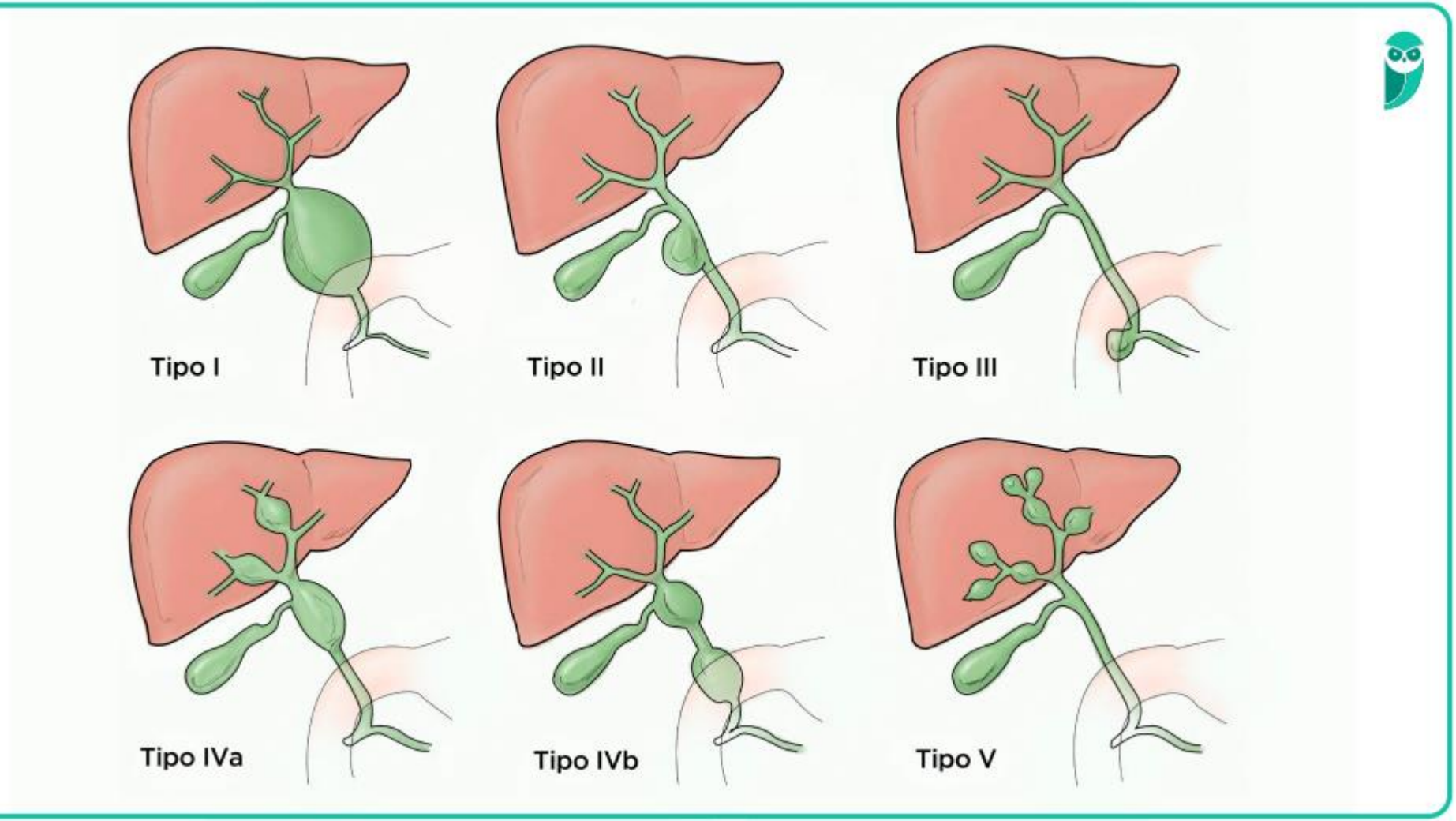
Outros: prurido; náuseas; perda ponderal



Renatha Paiva

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CLASSIFICAÇÃO DE TODANI



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CLASSIFICAÇÃO DE TODANI

Estratégia MED
TOME NOTA!



CLASSIFICAÇÃO DE TODANI DOS CISTOS BILIARES		
TIPO	**%**	**DESCRIÇÃO**
TIPO I	50-85%	Dilatação fusiforme extra-hepática
TIPO II	2%	Dilatação diverticular/sacular extra-hepática
TIPO III	1-5%	Coledococele (cisto na porção intraduodenal do colédoco)
TIPO IV	15-35%	IV A – Cistos intra-hepáticos e extra-hepáticos IV B – Múltiplos cistos extra-hepáticos
TIPO V	20%	Múltiplos cistos intra-hepáticos – doença de Caroli

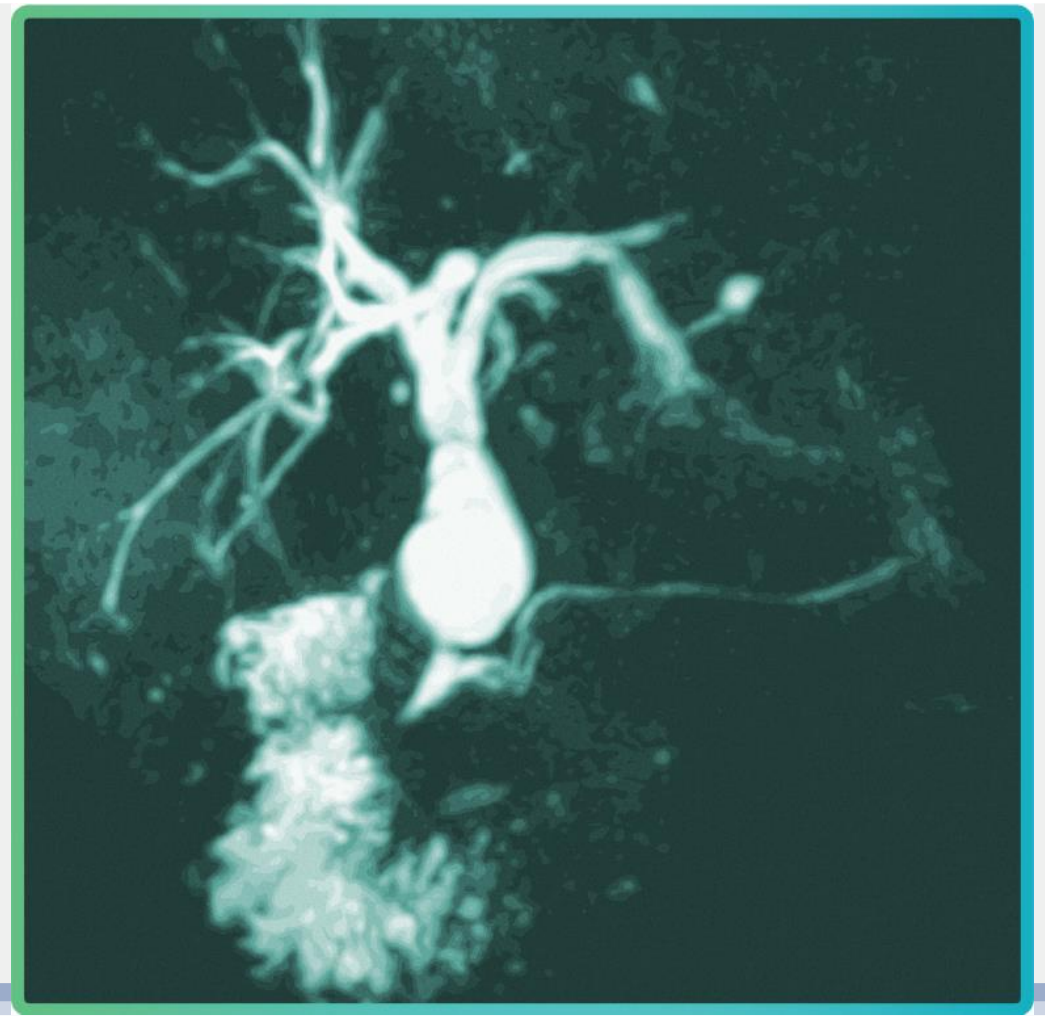
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

DIAGNÓSTICO

- Ultrassonografia: exame inicial (sensibilidade de 71% a 97%). Pode não diagnosticar alguns tipos de cistos, principalmente do tipo III.
- Tomografia computadorizada: pode detectar todos os tipos de cistos biliares.
- **COLANGIORRESSONÂNCIA:** é o exame de escolha, sensibilidade em torno de 73% a 100%.
- CPRE : visualização direta da papila duodenal, do colédoco e do ducto pancreático, permitir o diagnóstico de uma junção biliopancreática anômala.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

DIAGNÓSTICO





Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRATAMENTO

SEMPRE TEM INDICAÇÃO CIRÚRGICA!

Tipo I **Tipo II**	Colecistectomia associada à ressecção do segmento de colédoco acometido e reconstrução com hepaticoo-jejunostomia em Y-de-Roux;
Tipo III	Esfincterectomia endoscópica para cistos menores ou iguais a 3 cm e ressecção transduodenal com esfincterectomia para cistos acima de 3 cm;
Tipo IV	Ressecção da via biliar extra-hepática acometida e reconstrução com hepato-jejunostomia em Y-de-Roux Nos casos de cistos intra-hepática restritos a 1 lobo, pode-se considerar lobectomia ou segmentectomia.
Tipo V	Nos casos de doença de Carol, está indicado o transplante hepático e mcaso de doença difusa ou lovectomia em caso de doença localizada.

Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Uma paciente jovem apresenta colangites de repetição e colangioressonância sugerindo doença cística da via biliar com **múltiplas dilatações da árvore biliar extra hepática, sem alterações intra hepáticas**. O caso dessa paciente corresponde a qual tipo da Classificação de Todani?

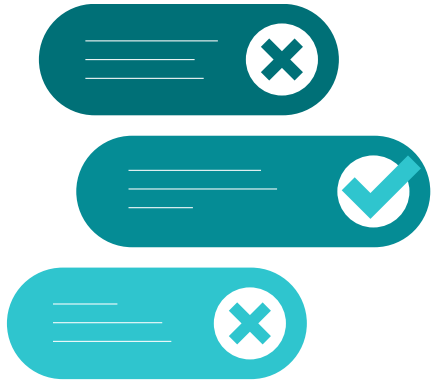
a) IVb

b) III

c) IVa

d) II

e) V



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CLASSIFICAÇÃO DE TODANI

Estratégia MED
TOME NOTA!



CLASSIFICAÇÃO DE TODANI DOS CISTOS BILIARES		
TIPO	**%**	**DESCRIÇÃO**
TIPO I	50-85%	Dilatação fusiforme extra-hepática
TIPO II	2%	Dilatação diverticular/sacular extra-hepática
TIPO III	1-5%	Coledococele (cisto na porção intraduodenal do colédoco)
TIPO IV	15-35%	IV A – Cistos intra-hepáticos e extra-hepáticos IV B – Múltiplos cistos extra-hepáticos
TIPO V	20%	Múltiplos cistos intra-hepáticos – doença de Caroli

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Uma paciente jovem apresenta colangites de repetição e colangioressonância sugerindo doença cística da via biliar com **múltiplas dilatações da árvore biliar extra hepática, sem alterações intra hepáticas**. O caso dessa paciente corresponde a qual tipo da Classificação de Todani?

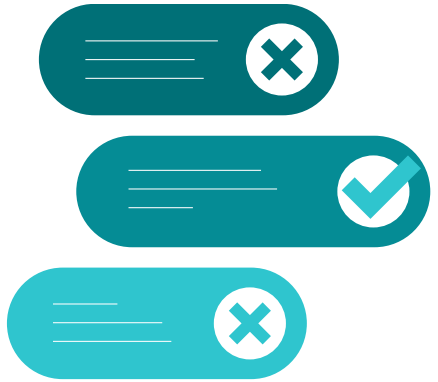
a) IVb

b) III

c) IVa

d) II

e) V



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

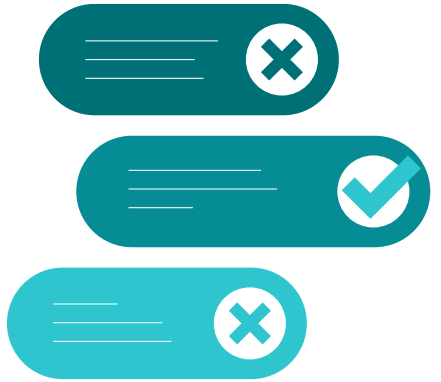
Nos pacientes jovens sem comorbidades e portadores de colelitíase sintomática, associada à dilatação cística das vias biliares extra-hepáticas tipo I de Todani, recomenda-se como a melhor opção terapêutica:

a) Realização da colecistectomia com derivação coledocojejunal em Y de Roux.

b) Realização da colecistectomia associada à papiloesfincterotomia endoscópica para descompressão biliar.

c) Realização da colecistectomia com derivação coledocoduodenal látero-lateral.

d) Realização da colecistectomia com ressecção da árvore biliar extra-hepática e derivação bileodigestiva em ""Y"" de Roux.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

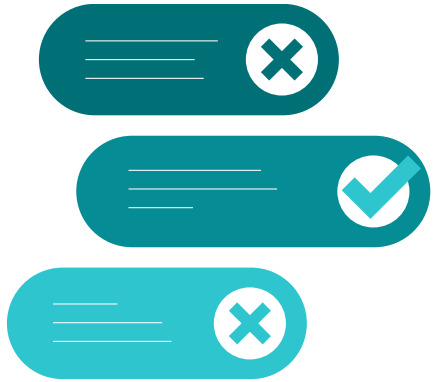
O tratamento da lesão cística da via biliar tipo III de Alonso-Lej Todani é:

A) Ressecção da lesão + coledocoduodenostomia.

B) Ressecção da lesão + hepaticojejunostomia.

C) Cistoduodenostomia.

D) Esfincterotomia endoscópica da ampola de Vate



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

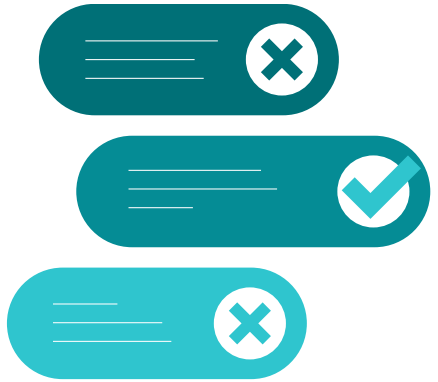
Em relação aos cistos de colédoco, assinale a afirmativa CORRETA:

A) O cisto tipo I é o mais comum, sendo que a maioria dos pacientes se apresenta com a tríade clássica: icterícia, dor abdominal e tumor palpável.

B) A doença de Caroli está indicada na classificação, representando 30% dos casos.

C) A ressecção cirúrgica é a base do tratamento das doenças císticas das vias biliares.

D) A drenagem biliar está indicada até nos casos assintomáticos.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

A respeito da imagem abaixo diagnosticada pela colangiografia endoscópica pode-se afirmar:

a) Corresponde a colangiocarcinona.

b) O tratamento ideal consiste em anastomose bileodigestiva na área dilatada.

c) A ressecção completa da lesão não está indicada pelo risco de sangramento.

d) A ressecção completa da lesão está indicada em decorrência do risco de degeneração maligna.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

A respeito da imagem abaixo diagnosticada pela colangiografia endoscópica pode-se afirmar:

a) Corresponde a colangiocarcinona.

b) O tratamento ideal consiste em anastomose bileodigestiva na área dilatada.

c) A ressecção completa da lesão não está indicada pelo risco de sangramento.

d) A ressecção completa da lesão está indicada em decorrência do risco de degeneração maligna.

Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

NEOPLASIA DA VESÍCULA BILIAR

Prof. Renatha Paiva

med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

EPIDEMIOLOGIA

- Rara
- Prognóstico ruim = estágios avançados (sobrevida global do câncer de vesícula é menor que 15%)
- 1 a 2% após colecistectomia = melhor prognóstico
- 6ª e 7ª décadas de vida
- Mais comum sexo feminino (2:1)
- 90% no fundo da vesícula biliar – assintomáticos
- perda ponderal e queda do estado geral, icterícia ou massa palpável



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

FATORES DE RISCO

INFLAMAÇÃO CRÔNICA DA MUCOSA DA VESÍCULA BILIAR

- **COLELITÍASE (principal fator de risco)**: 70 - 90%, cálculos > 3 cm
- Vesícula em porcelana: calcificação intramural, 95% tem cálculos
- Colangite esclerosante primária: inflamação, esclerose e obliteração progressiva das vias biliares extra-hepáticas e/ou intra-hepáticas. Associada a RCU;
- Cistos de colédoco:
- Junção biliopancreática anômala
- Infecção crônica por *Salmonella typhi*



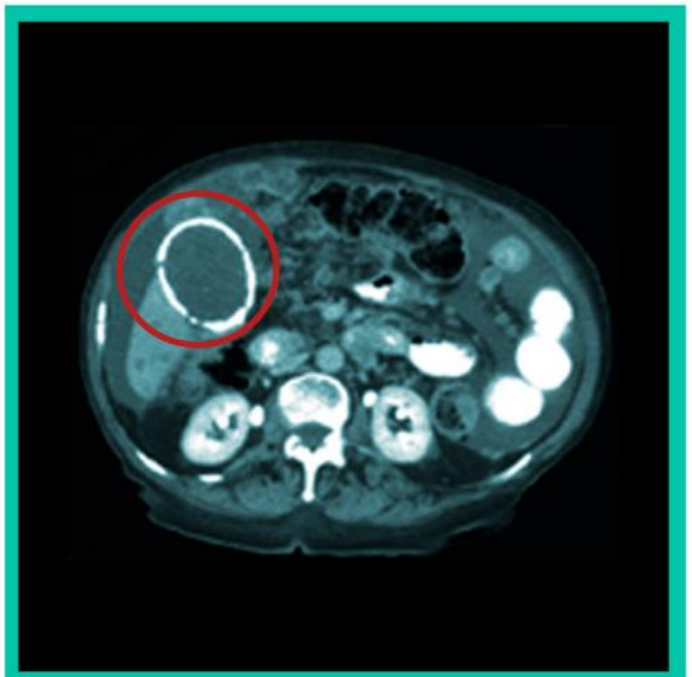
Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

FATORES DE RISCO

VESÍCULA EM PORCELANA



RADIOGRAFIA DE ABDOME



TOMOGRAFIA DE ABDOME



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

PATOLOGIA

ADENOCARCINOMA

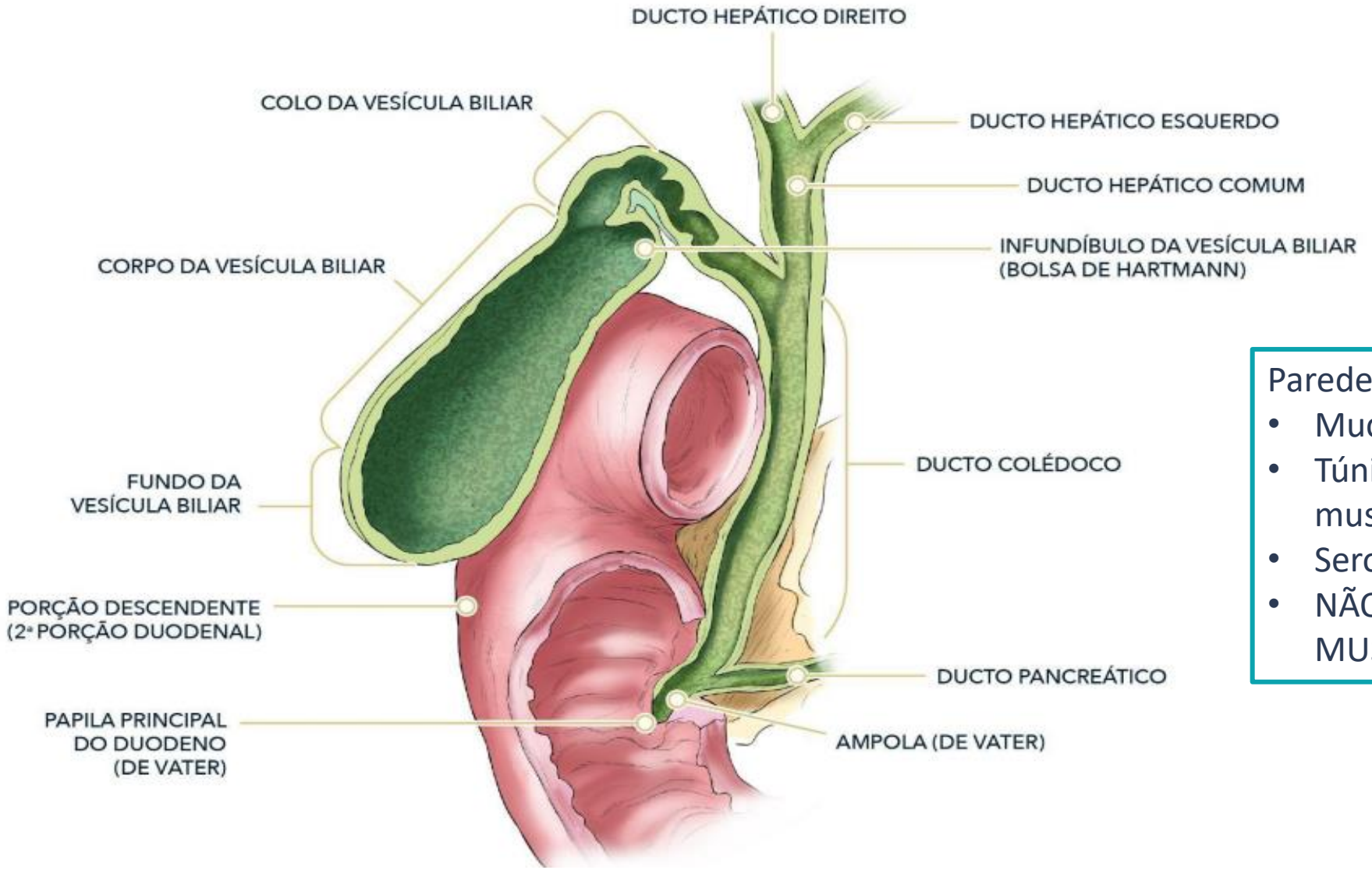
- **Papilar: menos de 10% dos tumores, prognóstico melhor;**
- **Nodular;**
- **Tubular**

- Disseminação: linfáticas, venosa e por invasão direta do parênquima hepático.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ANATOMIA DA VESÍCULA E VIA BILIAR



Parede da VB:

- Mucosa - lâmina própria
- Túnica fibromuscular: muscular e adventícia
- Serosa (vasos linfáticos)
- NÃO TEM SUBMUCOSA E MUSCULAR DA MUCOSA

Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Com relação ao câncer de vesícula biliar, é INCORRETO afirmar que:

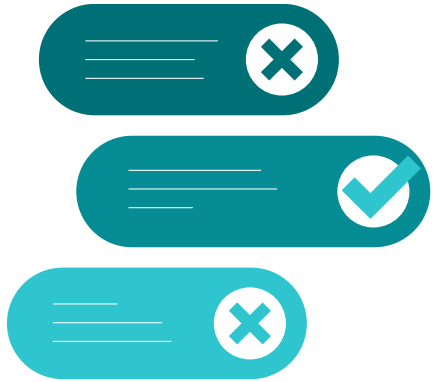
a) geralmente é adenocarcinoma.

b) o prognóstico costuma ser reservado.

c) colelitíase é fator de risco primário.

d) geralmente, há invasão hepática no diagnóstico.

e) a icterícia é um sinal precoce



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Mulher de 46 anos procura atendimento médico com relato de dor epigástrica intensa há 3 dias, que se irradia para hipocôndrio e flanco direitos, associada a náuseas, vômitos e febre de 37,4 ºC. No interrogatório complementar, refere intolerância a alimentos gordurosos. Nega icterícia. A equipe médica solicitou RX de abdome e ultrassonografia abdominal, cujo resultado foi vesícula em porcelana. Diante dos resultados dos exames e do quadro clínico da paciente, assinale a alternativa correta.

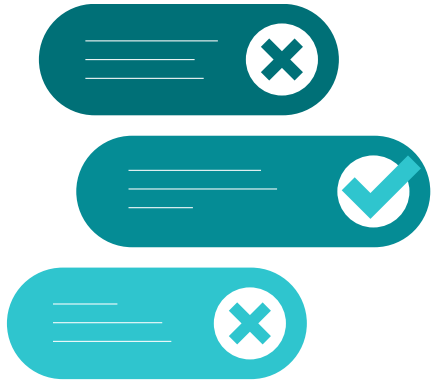
a) O tratamento da paciente deve ser clínico, com uso de antibióticos e sintomáticos ambulatorial.

b) A paciente pode receber alta sem indicação de cirurgia, pois a patologia não apresenta evolução desfavorável.

c) Há indicação de colecistectomia, pois a vesícula em porcelana é condição que predispõe ao câncer da vesícula biliar.

d) Deve-se indicar para a paciente colangiorressonância para melhor elucidação diagnóstica pela presença da tríade de Charcot.

e) Há indicação de punção percutânea da vesícula biliar para coleta da bile e análise da celularidade e microbiológica.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

DIAGNÓSTICO

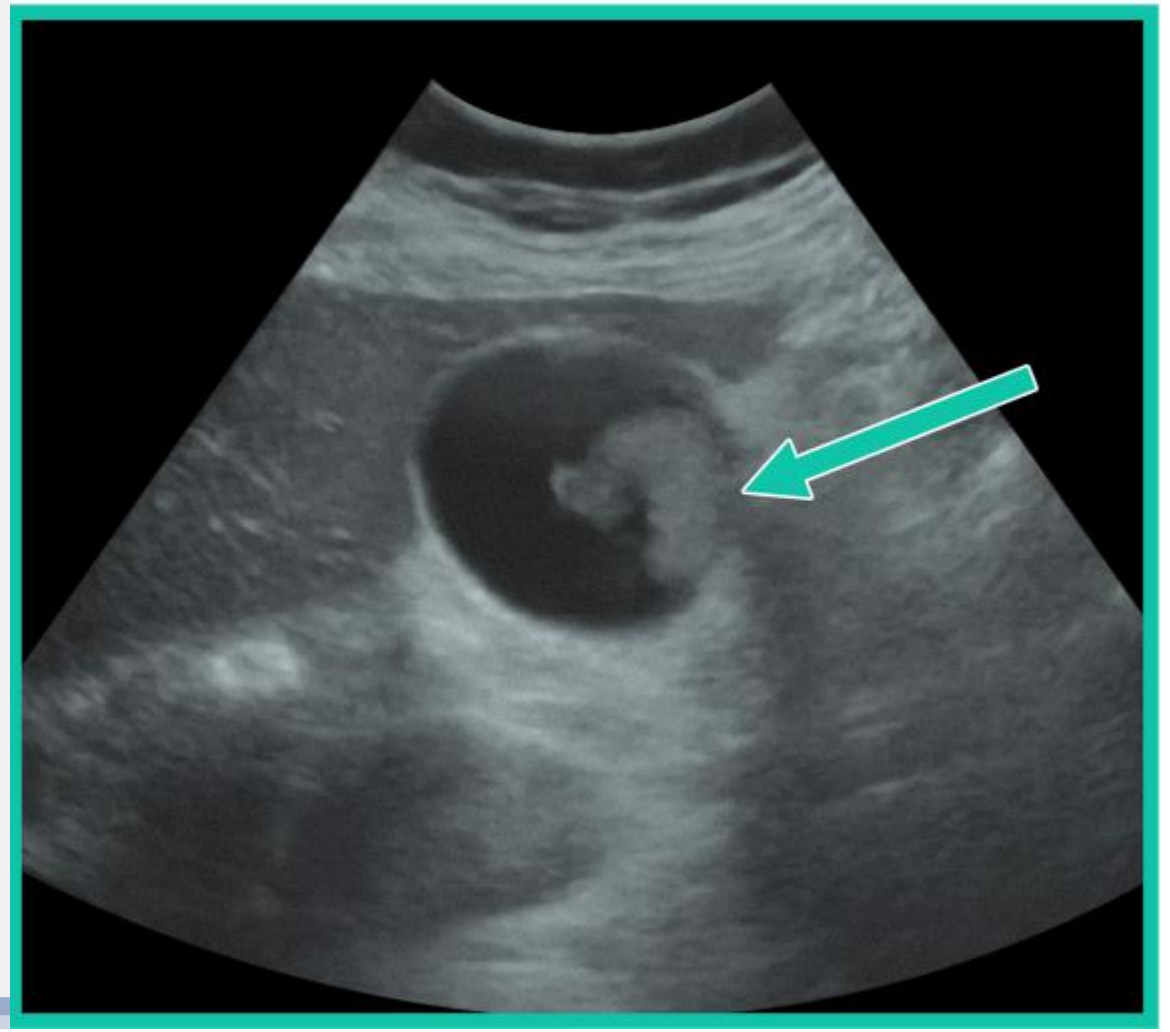
- **CLÍNICA**: maioria assintomático (90% origina-se no fundo), perda ponderal e queda do estado geral, icterícia ou massa palpável.
- **USG** = exame inicial, sensibilidade de 70 a 100%
- **Tomografia computadorizada**: estadiamento, avaliação de invasão de órgãos ou estruturas vasculares adjacentes, diagnóstico de metástases a distância.
- **RNM:** superior à TC, envolvimento nodal, vascular, biliar, hepático e de órgãos adjacentes



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

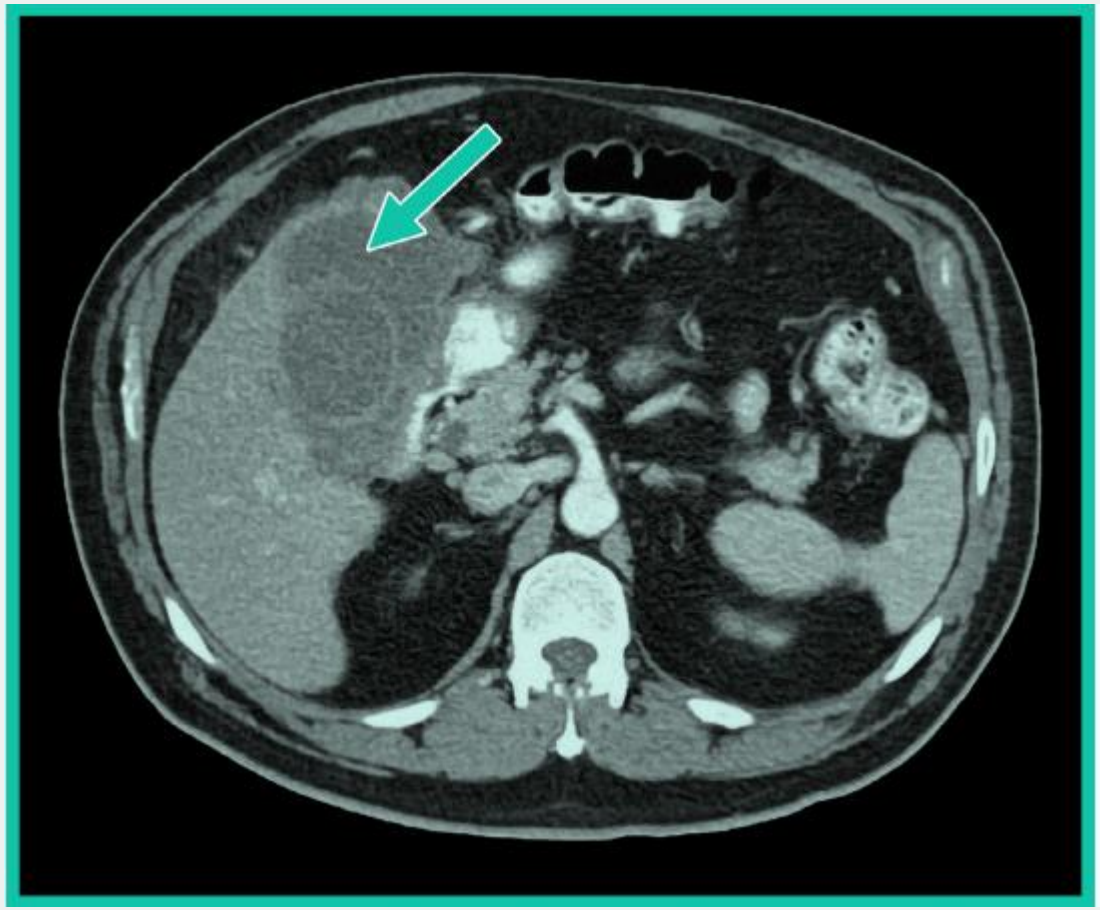
ULTRASSONOGRAFIA

- Espessamento assimétrico;
- Calcificação mural;
- Massa projetando-se para a luz da vesícula biliar;
- Massa fixa na parede da vesícula;
- Infiltração direta no fígad



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TOMOGRAFIA



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ESTADIAMENTO

TUMOR PRIMÁRIO (T)	
TX	Tumor primário não pode ser avaliado
T0	Sem evidência de tumor primário
Tis	Carcinoma *in situ*
T1	Tumor invade a lâmina própria ou muscular
T1a	Tumor invade a lâmina própria
T1b	Tumor invade a camada muscular
T2	Tumor invade o tecido conjuntivo perimuscular no lado peritoneal, sem envolvimento do peritônio visceral OU Tumor invade o tecido conjuntivo perimuscular no lado hepático, sem extensão para o fígado
T2a	Tumor invade o tecido conjuntivo perimuscular no lado peritoneal, sem envolvimento do peritônio visceral
T2b	Tumor invade o tecido conjuntivo perimuscular no lado hepático, sem extensão para o fígado
T3	Tumor perfura a serosa (peritônio visceral) e/ou invasão direta hepática e/ou invasão de 1 órgão ou estrutura adjacente, como: estômago, duodeno, cólon, pâncreas, omento ou via biliar extra-hepática.
T4	Tumor invade veia porta ou artéria hepática OU invasão de 2 ou + órgãos ou estruturas extra-hepáticas



Medicina livre, venda proibida. twitter @livremedicina

ESTADIAMENTO

DOENÇA METASTÁTICA CONTRAINDICA A RESSECÇÃO CIRÚRGICA

LINFONODOS REGIONAIS (N)	
NX	Linfonodos não podem ser avaliados
N0	Sem linfonodos comprometidos
N1	Metástase de 1 a 3 linfonodos regionais
N2	Metástase de 4 ou mais linfonodos regionais
METÁSTASES A DISTÂNCIA (M)	
M0	Sem metástase a distância
M1	Metástase a distância

Linfonodos ducto cístico, do ducto biliar comum, da artéria hepática e das veias portais

Linfonodos para-aórtico, paracaval, AMS e tronco celíaco

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ESTADIAMENTO TNM DO CÂNCER DE VESÍCULA (AJCC 8ª EDIÇÃO)		
TUMOR PRIMÁRIO (T)		CONDUTA CIRÚRGICA
T1a	Tumor invade a lâmina própria	Colecistectomia simples; o risco de margens positivas ou linfonodos positivos é muito baixa, não sendo necessário complementar o tratamento.
T1b	Tumor invade a camada muscular	Ampliação das margens, com ressecção do leito hepático, associado a linfadenectomia
T2	Tumor invade o tecido conjuntivo perimuscular no lado peritoneal, sem envolvimento do peritônio visceral OU Tumor invade o tecido conjuntivo perimuscular no lado hepático, sem extensão para o fígado	Hepatectomia dos segmentos IVb e V, associado a linfadenectomia
T3	Tumor perfura a serosa (peritônio visceral) e/ou invasão direta hepática e/ou invasão de 1 órgão ou estrutura adjacente, como estômago, duodeno, cólon, pâncreas, omento ou via biliar extra-hepática.	Hepatectomia dos segmentos IVb e V, associado a linfadenectomia, nos casos que que há somente a perfuração da serosa. A ressecção em monobloco com outros órgãos deve ser restrita a grandes centros.

Estratégia MED

85 a 100% sobrevida em 5 anos

- ducto cístico,
- pericoledocociana, hepatoduodenal,
- celíaca-direita pancreaticoduodenal posterior

20 a 60% sobrevida em 5 anos

< 20 % sobrevida em 5 anos

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

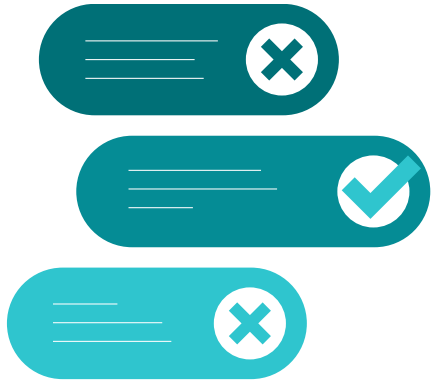
A respeito das neoplasias da vesícula biliar, assinale a alternativa incorreta.

a) São menos comuns em homens.

b) De acordo com a classificação TNM/AJCC, um tumor que perfura a serosa e invade o duodeno é classificado como T4.

c) O diagnóstico precoce constitui a minoria dos casos.

d) Em caso de pólipos de vesícula biliar maiores que 10 mm, está indicada a colecistectomia e deve-se evitar a via laparoscópica.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Paciente com colicistite crônica calculosa é submetido a colecistectomia. No exame anatomopatológico, vem o diagnóstico de adenocarcinoma de vesícula biliar T1A. Assinale a opção que apresenta a melhor conduta.

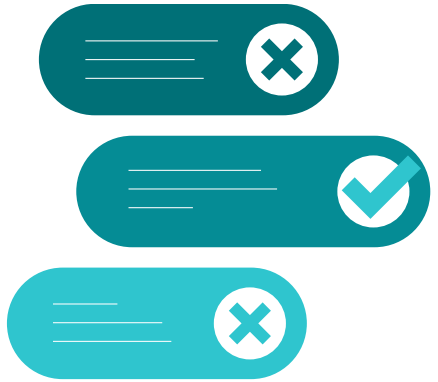
a) Hepatectomia direita.

b) Somente a colecistectomia realizada.

c) Hepatectomia esquerda.

d) Hepatectomia central.

e) Ressecção do leito hepático, onde se encontrava a vesícula biliar.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Mulher, 50 anos de idade, que apresentava litíase biliar sintomática, foi submetida a colecistectomia videolaparoscópica eletiva que transcorreu sem problemas e recebeu alta no 2º dia de pós-operatório. Uma semana depois, o cirurgião a chamou para avisá-la de que, ao exame, a peça cirúrgica revelou a presença de adenocarcinoma de parede da vesícula biliar. O câncer é limitado à camada muscular da vesícula biliar e, no ducto cístico, a margem é negativa. Na subsequente conversa com a paciente, o que deveria ser recomendado como plano de tratamento?

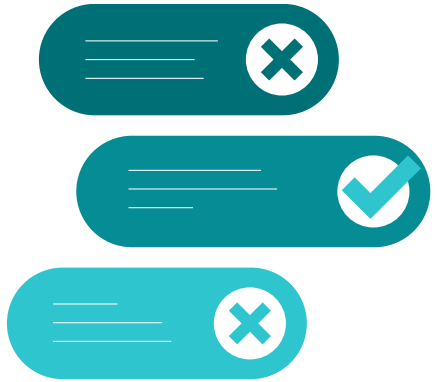
a) Ressecção da fossa hepática da vesícula biliar e linfadenectomia portal.

b) Ressecção dos locais de punção dos trocartes da laparoscopia e quimioterapia com 5-fluoracil.

c) Radioterapia e quimioterapia com 5-fluoracil.

d) Hepatectomia dos segmentos IVa e V, linfadenectomia portal e ressecção com reconstrução da via biliar extra-hepática.

e) Nenhum tratamento adicional é necessário.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Mulher, 57 anos, submetida à colecistectomia laparoscópica, sem intercorrências. Não houve perfuração da vesícula biliar, e a peça cirúrgica foi retirada com saco plástico. No 14º DPO, retorna com o histopatológico que descreve: "...no infundíbulo, observa-se adenocarcinoma invadindo tecido conjuntivo perimuscular sem extensão, além da serosa ou fígado. Linfonodo de Mascagni livre de células tumorais". Qual a melhor conduta ?

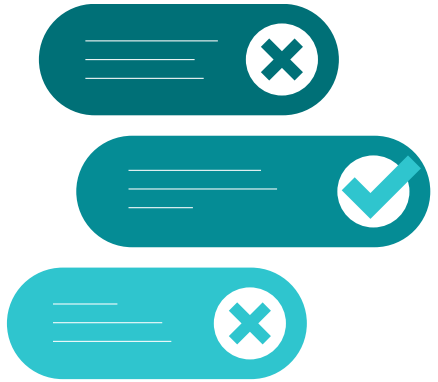
a) Não cirúrgica. Conduta expectante.

b) Quimioterapia neo adjuvante com gencitabina.

c) Ressecção dos segmentos 4b/5 mais linfadenectomia.

d) Hepatectomia esquerda.

e) Ressecção do cístico e da via biliar principal.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

COLANGIOCARCINOMA

Prof. Renatha Paiva

med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

COLANGIOCARCINOMA

- ✓ Tumor raro que surge no epitélio dos ductos biliares (3% CA TGI)
- ✓ 50 a 70 anos, mais comum sexo masculino
- ✓ 95% adenocarcinomas (**esclerosante,** nodular ou papilífero)
- ✓ Porção intra-hepática, peri-hilar e porção distal
  - 2/3 (60%-70%) junto ao hilo hepático (peri-hilares)
  - 5% - 10% são intra-hepáticos.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

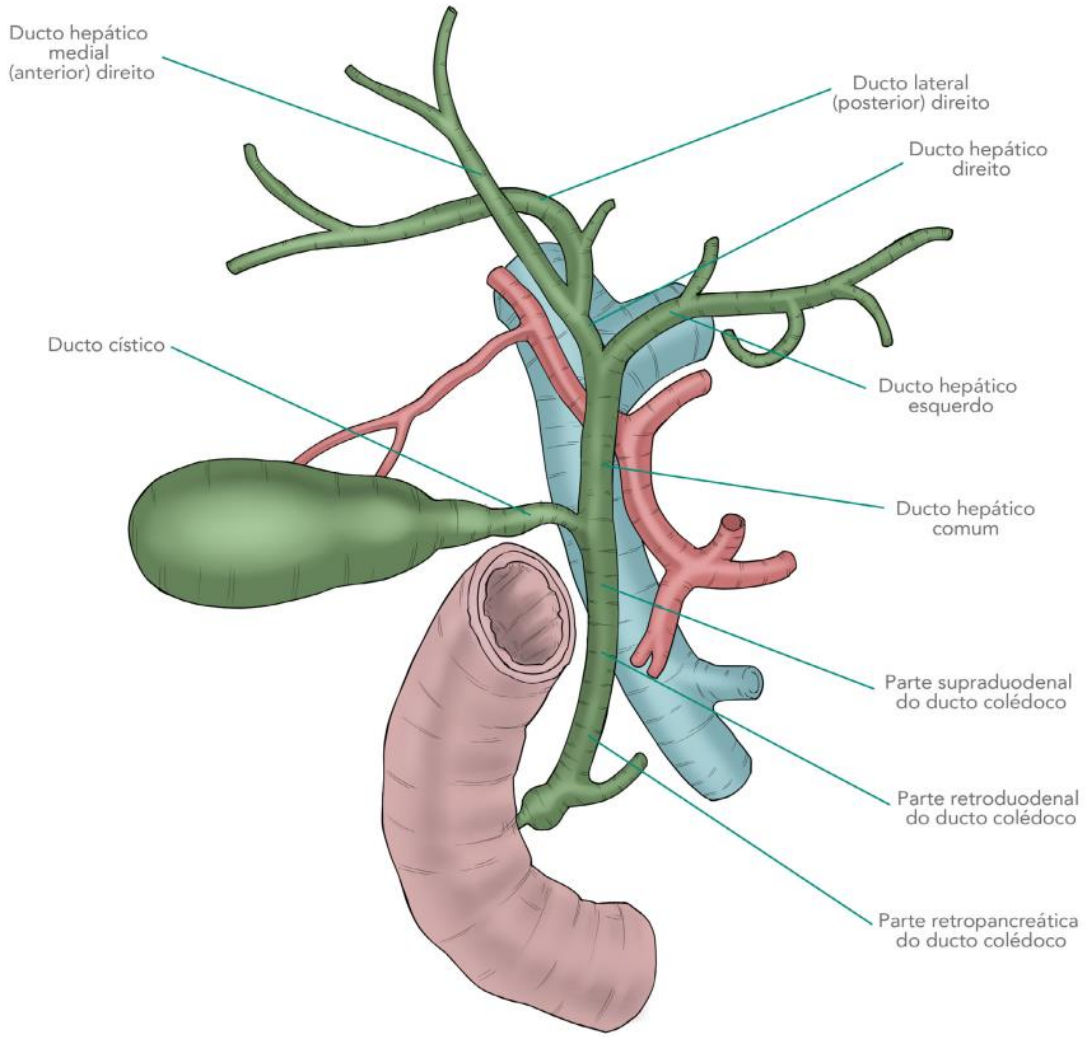
FATORES DE RISCO

- Colangite esclerosante primária: risco estimado de 5% a 15%. Associada a RCU;
- Cistos de colédoco: risco estimado de 15%.
- Litíase biliar intra-hepática, ou colangite piogênica recorrente:
- Doença hepática crônica: 3,5% em 10 anos
- Síndrome de Lynch
- Mutação do BRCA
- Fibrose cística: risco aumenta (2x a 5x) nos pacientes submetidos a transplante pulmonar;
- Thorotrast (agente de contraste radiológico banido na década de 1960 por suas propriedades carcinogênicas)
- Infecção parasitária: *Clonorchissinensis e Opisthorchis viverrini , Salmonella typhi*



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

COLANGIOCARCINOMA



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TUMOR DE KLATSKIN (tumores peri-hilares)

70% dos colangiocarcinomas, 95% **adenocarcinomas** (**esclerosante**, nodular ou papilífero)

Mais comum no sexo masculino, 50 a 70 anos de idade

Fatores de risco (inflamação crônica da árvore biliar):

- Colangite esclerosante primária: risco de 5 a 15 %, 30 a 50 anos
- Cistos congênitos da via biliar
- Litíase biliar intra-hepática, ou colangite piogênica recorrente
- Doença hepática crônica
- Síndrome de Lynch
- Fibrose cística
- Thorotrast (um agente de contraste radiológico banido na década de 1960)
- Infecção parasitária: *Clonorchis sinensis e Opisthorchis viverrini, Salmonella typhi*



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

COLANGIOCARCINOMA

- Crescimento lento, alta taxa de invasão local, produção de mucina e tendência a invadir as bainhas perineurais e se espalhar ao longo dos nervos.
- Metástases a distância são incomuns

CLÍNICA:

- Icterícia de padrão obstrutivo
- Sintomas constitucionais: perda ponderal, anorexia, fadiga, podem estar presentes.
- Não há presença de vesícula de Courvoisier-Terrier (TUMOR DE KLATSKIN)

DIAGNÓSTICO:

- **Principal marcador:** CA 19-9 (sensibilidade de 79% e uma especificidade de 98% > 129U/mL.)
- Imagem: USG – TC- **COLANGIORRESSONÂNCIA**



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Homem de 69 anos de idade, com etilismo social, referiu urina escura há um mês e ao exame físico apresentava esclera discretamente amarelada. Panículo adiposo espesso impediu palpação das vísceras abdominais. Nos exames, constatou-se AST de 80 U/L, ALT 120 U/L, bilirrubina total de 4 mg/dL às custas da fração direta, fosfatase alcalina de 200 U/L, GGT de 150 U/L, TP de 16 s, RNI de 1,50, albumina de 3,5 g/dL, CEA de 1 mcg/L (normal até 5 mcg/L), AFP de 10 mcg/L (normal até 15 mcg/L), CA 19-9 de 200 U/mL (normal até 37 U/mL). A seguir, fez US de abdome superior. Qual dos achados ultrassonográficos abaixo é compatível com o quadro clínico e laboratorial?

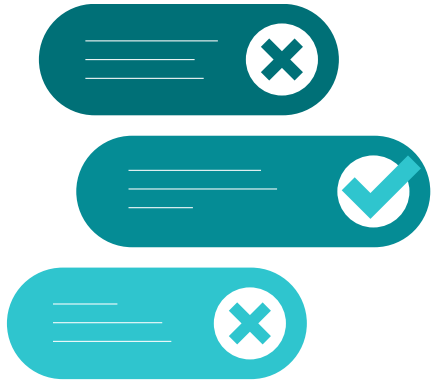
a) Dilatação de ducto colédoco

b) Múltiplas lesões hepáticas em alvo

c) Massa sólida no fígado

d) Superfície hepática irregular e nodular

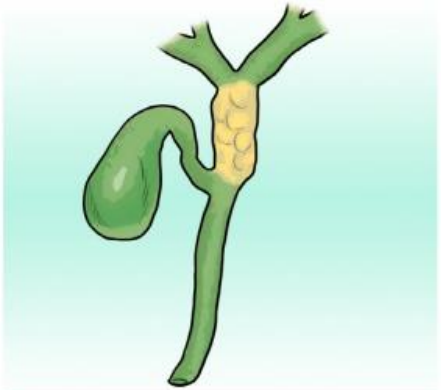
e) Vesícula biliar em porcelana



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

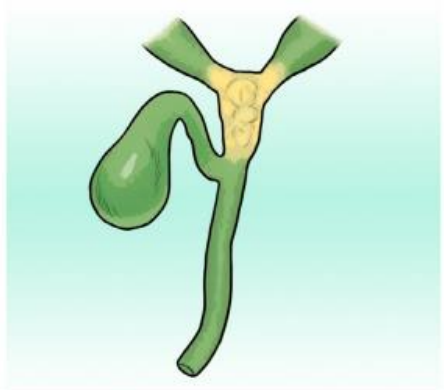
Classificação de Bismuth-Corlette

TIPO I



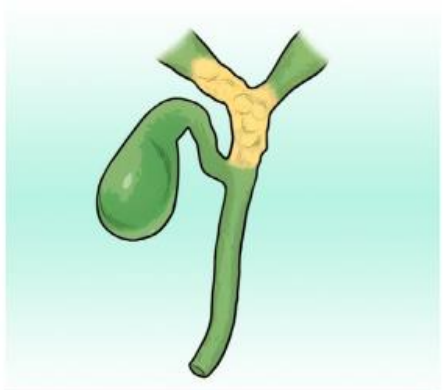
Tumores abaixo da confluência dos ductos hepáticos

TIPO II



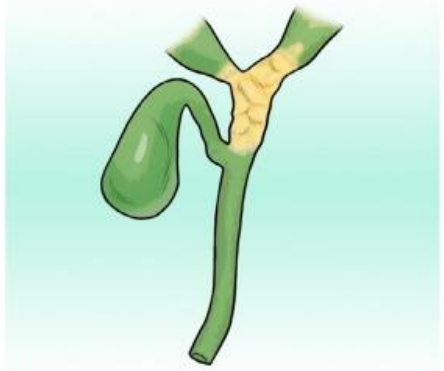
Tumores acometendo a confluência dos ductos hepáticos

TIPO IIIa



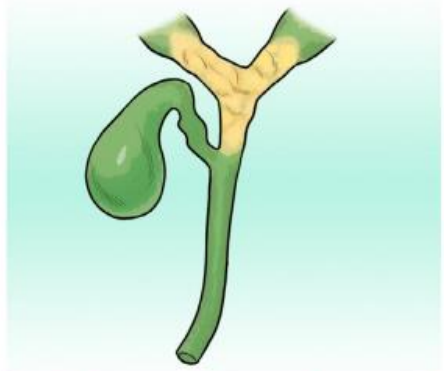
Tumores envolvendo o ducto hepático comum e o ducto hepático direito

TIPO IIIb



Tumores envolvendo o ducto hepático comum e o ducto hepático esquerdo

TIPO IV



Tumores que envolvem a confluência e se estendem para o ducto hepático direito e esquerdo

TUMOR DE KLATSKIN

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

De acordo com a classificação de Bismuth-Corlette, a lesão neoplásica que afeta a bifurcação e o ducto hepático esquerdo, também conhecido como tumor de Klatiskin, é:

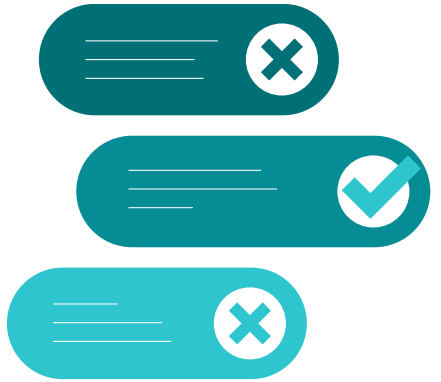
a) Tipo-I;

b) Tipo-II;

c) Tipo-IIIa;

d) Tipo-IIIb;

e) Tipo- 0-IIb;



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TUMOR DE KLATSKIN

TRATAMENTO: CIRÚRGICO – SOMENTE RESSECÇÃO R0 (MARGENS LIVRES)

Critérios para ressecabilidade:

- Ausência de metástases nodais retropancreáticas e paracelíacas ou metástases hepáticas distantes;
    - ❖ Os linfonodos hilares, do ducto cístico, do colédoco, periportal, junto à artéria hepática e pancreaticoduodenais posteriores são classificados como linfonodos regionais;
- Ausência de invasão da veia porta ou artéria hepática principal;
- Ausência de invasão extra-hepática de órgãos adjacentes;
- Ausência de doença disseminada

Principais fatores prognósticos: margens histológicas negativas e status linfonodal



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

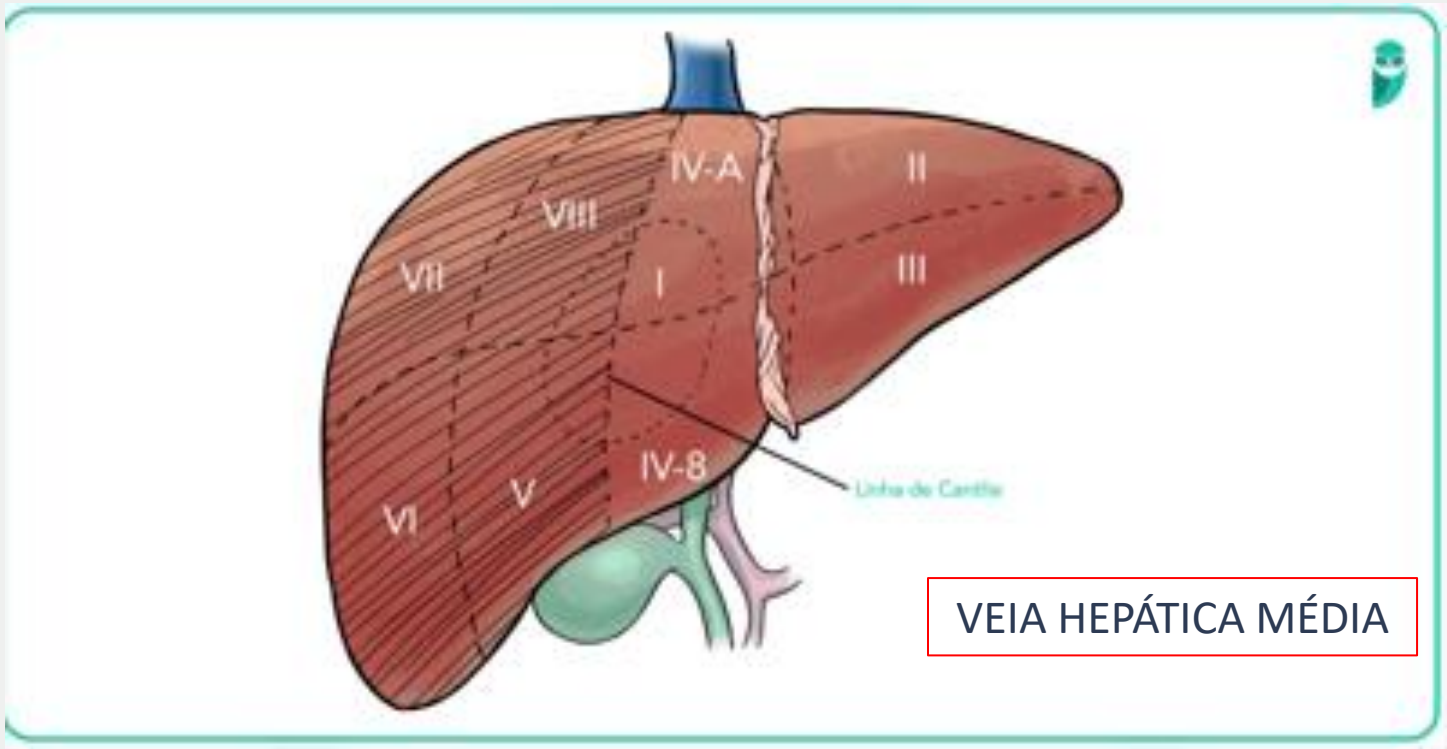
TUMOR DE KLATSKIN - CIRURGIA

- **Tipo I e II:** ressecção da via biliar extra-hepática com reconstrução com hepaticojejunostomia em Y-de-Roux associado à linfadenectomia.
- **Tipo III a**: ressecção da via biliar extra-hepática + trissectorectomia direita (IV, V, VI, VII e VIII) + ressecção do lobo caudado com anastomose hepaticojejunal com o ducto hepático esquerdo em Y-de-Roux associado à linfadenectomia locorregional;
- **Tipo III b:** ressecção da via biliar extra-hepática + hepatectomia esquerda (II, III, IV) + ressecção do lobo caudado com anastomose hepaticojejunal com o ducto hepático direito em Y-de Roux associado à linfadenectomia locorregional;
- **Tipo IV:** esse tipo de tumor é frequentemente irressecável. Os casos potencialmente ressecáveis devem ser encaminhados a centros especializados



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ANATOMIA DA VESÍCULA E VIA BILIAR



VEIA HEPÁTICA MÉDIA

Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

COLANGIOCARCINOMA

- **COLANGIOCARCINOMA INTRA-HEPÁTICO:** geralmente tratado com ressecção hepática. O principal fator prognóstico é a obtenção de margens negativas. Se houver acometimento linfonodal hilar grosseiro, a ressecção não é recomendada, visto que o prognóstico é extremamente ruim.
- **COLANGIOCARCINOMA DISTAL:** duodenopancreatectomia (cirurgia de Whipple)



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

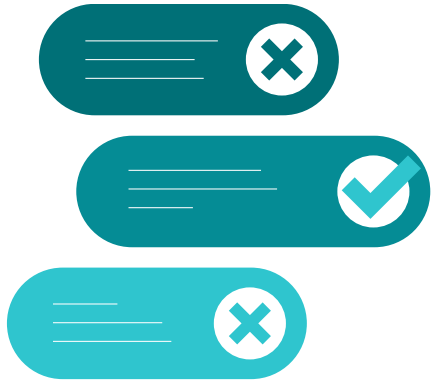
Idoso de 72 anos, tabagista, procura o ambulatório de clínica médica, queixando-se de prurido e alteração da cor dos olhos e da pele. Ao exame físico, apresentava-se ictérico e hipocorado. À palpação de abdômen, evidenciou-se massa indolor de cerca de 5 cm em região de hipocôndrio direito de consistência cística, e exames laboratoriais revelaram anemia, hiperbilirrubinemia e elevação de enzimas canaliculares. Nesse caso, o diagnóstico mais provável é:

a) colangiocarcinoma distal

b) câncer de vesícula

c) tumor de Klatskin

d) hepatocarcinoma



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Paciente procura ambulatório de Gastroenterologia com quadro de icterícia. No exame físico, presença de vesícula palpável, indolor. Esses achados definem o Sinal de Courvoisier. Dos tumores abaixo, qual não cursa com esse sinal:

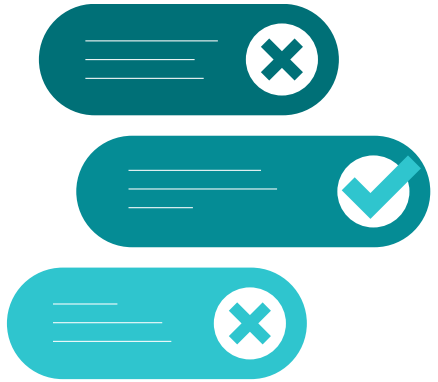
a) De cabeça de pâncreas.

b) De vesícula biliar.

c) De papila duodenal.

d) De colédoco distal.

e) De Klatskin.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

O colangiocarcinoma é um tumor infrequente, que pode ocorrer em qualquer segmento do trato biliar. Sobre esse tumor, assinale a alternativa CORRETA:

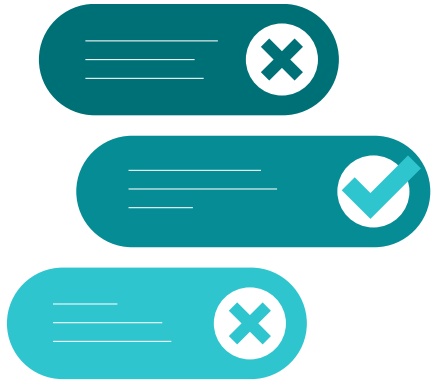
a) A localização mais frequente é a confluência dos ductos hepáticos.

b) O tumor de Klatskin pode ser tratado com a duodenopancreatectomia.

c) A ressecção está contraindicada em tumores distais maiores que 2 centímetros.

d) A presença de linfonodos portais hipertrofiados à USG endoscópica contraindica a ressecção de tumores hilares.

e) O tratamento do tipo IV de Bismuth-Corlette é uma hepatectomia direita.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

Homem, 63 anos, icterícia indolor há 1 mês. Perda de 6 kg. Ao exame, apresenta fígado pouco aumentado e vesícula não palpável. USG - dilatação de vias biliares intra- hepáticas e CA 19.9 - 900. Colangioressonância mostra lesão estenótica de hepático comum, sem acometer a confluência. Qual a classificação de Bismuth - Corlette e a conduta cirúrgica adequada?

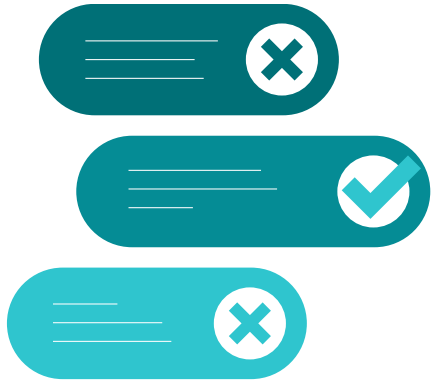
a) Tipo I. Ressecção da via biliar extra-hepática + hepaticojejunostomia em Y Roux

b) Tipo II, Hepatectomia D. + ressecção do caudado + Ressecção de via biliar extra-hepática com hepaticojejunostomia em Y Roux

c) Tipo IIIa. Hepatectomia D. Ressecção de via biliar extra-hepática com hepaticojejunostomia em Y Roux

d) Tipo IIIb. Hepatectomia E. + ressecção do caudado + Ressecção de via biliar extra-hepática com hepaticojejunostomia em Y Roux

e) Tipo IVa . Hepatectomia D. + ressecção do caudado + Ressecção de via biliar extra-hepática com hepaticojejunostomia em Y Roux



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Estratégia MED

OBRIGADA



prof.renathapaiva

estrategiamed

med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina